

Guide de facturation

JUIN 2026

CABINET

FACNET.CA
+1 866 332 2638

FACNET



Guide de facturation

Cabinet

Note : L'information contenue dans ce document peut être expirée ou incomplète. Toujours vous référer aux manuels de facturation fournis par la RAMQ au www.ramq.gouv.qc.ca.

Visites	3
Médecin traitant sur RDV ou accès adapté	4
Tout médecin au SRV et médecin non traitant sur RDV	6
Tout médecin – RDV ou Accès adapté	7
Tout médecin sauf médecin traitant sur RDV ou en Accès adapté	9
Tout médecin sur RDV, Accès adapté ou SRV (patient inscrit ou non)	10
Autres actes permis	12
Visites à domicile	23
Autres précisions	25
Déplacement d'urgence	27
Frais de cabinet	32
Frais de cabinet DMÉ	36
Pratique en GMF (EP33)	38
Pratiques Cliniques-Réseaux GMF-AR (EP54)	40
Inscription de la clientèle	41
Médecin enseignant	46
CNESST	49
IVAC	52
Codes de médicaments et patients d'exception	53
GAP - lettre d'entente 393	54
Formation continue (Annexe XIX)	57
Séjour de formation (Annexe XII)	60
Facturation Hors RAMQ	62
Grille provinciale des tarifs	65
ANNEXE 1 – Codes des visites de facturation	66
ANNEXE 2 – Actes fréquemment utilisés	69
ANNEXE 3 – Les actes inclus	75

Le présent guide a été conçu pour que vous puissiez le consulter à l'écran ou sous format papier. Pour visualiser les différents sujets à l'écran, vous pouvez cliquer sur le sujet via la table des matières ou l'icône de Signet pour que la table des matières s'affiche à droite et facilite vos recherches.

Visites

Pour les codes de facturation, veuillez vous référer à l'annexe 1.

La tarification de la facturation en cabinet est modulée selon :

- L'âge du patient de moins de 80 ans ou de 80 ans et plus
- Qu'un patient soit inscrit ou non vulnérable (par le biais de la pratique de groupe pour les visites facturables lorsqu'il ne s'agit pas du médecin traitant)
- Compte 500 patients inscrits ou non (tarification bonifiée)
 - L'évaluation se fait à chaque trimestre
 - Les inscriptions n'ont pas à être actives
 - Pas de pondération pour les patients vulnérables

P.S. Prendre note que pour la modulation des 500 patients inscrits, le médecin se verra coupé au complet s'il n'a pas 500 patients d'inscrits, car la visite et la vulnérabilité sont maintenant facturées ensemble. La date de référence pour le calcul du nombre de patients inscrits auprès d'un médecin est le 1^{er} mars, le 1^{er} juin, le 1^{er} septembre et le 1^{er} décembre.

Dès que vous atteignez 500 patients, il est important de nous aviser pour mettre votre dossier à jour car la nomenclature de codes à utiliser est différente.

Date d'évaluation	Validité
1er mars	1er avril
1er juin	1er juillet
1er septembre	1er octobre
1er décembre	1er janvier

ENTENTE DRMG

Le médecin qui détient un permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis moins d'un an peut se prévaloir de la tarification bonifiée prévue à la nouvelle nomenclature des actes, s'il s'engage auprès de son Département régional de médecine générale (DRMG) à effectuer la prise en charge et le suivi d'au moins 500 patients au terme de quatre trimestres complétés. Il peut se prévaloir de cette tarification pour un maximum de quatre trimestres complets à la suite de l'obtention de son permis de pratique.

Afin de démontrer son engagement auprès de son DRMG, le médecin doit acheminer au Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie une lettre précisant :

- son nom, prénom et numéro de professionnel ;
- la date à partir de laquelle il s'est engagé auprès de son DRMG.

Cette lettre doit être signée par le médecin. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit contresignée par le DRMG.

Vous trouverez un exemple de lettre de confirmation d'engagement auprès du DRMG à adresser à la Régie à la fin de l'infolettre suivante :

<https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info074-6.pdf>

À noter que vous ne serez pas pénalisé si, au bout des quatre trimestres, vous n'avez pas atteint le nombre de 500 patients.

Médecin traitant sur RDV ou accès adapté

VISITE DE PRISE EN CHARGE

Moins de 500 patients : 15801 - 15815 - 15821 - 15835

Plus de 500 patients : 15802 - 15816 - 15822 - 15836

S'applique lors d'une inscription d'un patient orphelin ou non en vue d'un suivi longitudinal, facturable une seule fois lors de l'inscription. Inclut l'évaluation, le plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les échanges courants avec le patient ou ses proches et, lorsqu'indiqué, le counseling pour cessation tabagique de même que les autres actes préventifs pertinents.

Depuis le 1^{er} juin 2019, lorsque le médecin veut inscrire un patient qu'il a vu au sans rendez-vous, il peut l'inscrire à la visite du sans rendez-vous, mais devra revoir le patient ultérieurement dans un rendez-vous pour facturer la visite de prise en charge.

VISITE DE SUIVI D'UN PATIENT INSCRIT

Moins de 500 patients : 15803 - 15817 - 15823 - 15837

Plus de 500 patients : 15804 - 15818 - 15824 - 15838

S'applique lors d'une visite de suivi ou d'évaluation pour un problème ponctuel. Un contact avec le patient et, au besoin, l'examen, l'élaboration, le plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les échanges courants avec le patient et ses proches. Inclut le counseling pour cessation tabagique de même que les autres actes préventifs pertinents. **Facturable au besoin.**

VISITE PÉRIODIQUE DU VULNÉRABLE

Moins de 500 patients : 15819 - 15839

Plus de 500 patients : 15820 - 15840

Patient vulnérable déjà inscrit auprès du médecin et suivi par lui. Vise à évaluer l'évolution du patient et la mise à jour du plan de traitement. Inclut l'évaluation, le plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les échanges courants avec le patient ou ses proches et, lorsqu'indiqué, le counseling pour cessation tabagique de même que les autres actes préventifs pertinents.

Facturable une seule fois par année civile (1er janvier au 31 décembre). Ne peut pas être facturée la même année que la visite de prise en charge, que l'examen complet majeur ainsi que pour la visite de prise en charge de grossesse, l'examen de prise en charge de grossesse et le supplément à l'examen de prise en charge de grossesse durant le 1^{er} trimestre. **Pas de visite périodique pour les patients non vulnérables ou non inscrits auprès du médecin.**

VISITE PÉRIODIQUE PÉDIATRIQUE

Moins de 500 patients : 15813 - 15833

Plus de 500 patients : 15814 - 15834

Enfant de 0-63 mois inscrit auprès du médecin. Vise le dépistage des problèmes de développement et l'évaluation dans le cadre d'un suivi ou d'une évaluation pour un problème ponctuel. La visite inclut le supplément de l'ABCdaire. Exigences de la visite de suivi d'un patient inscrit PLUS évaluation des éléments pertinents de l'abécédaire.

Un nombre maximum de services est prévu pour la rémunération spécifique de la visite périodique pédiatrique. Pour un même patient, sont comptabilisés à cette fin :

- la visite de prise en charge lors de l'inscription ;
- la visite périodique d'un patient vulnérable ;
- la visite périodique pédiatrique ;
- l'intervention clinique pour la clientèle pédiatrique ;
- le supplément de responsabilité à l'examen périodique d'un enfant âgé de 0 à 5 ans.

Le nombre maximal de ces services pouvant être facturé est :

- de 0-21 mois : 8 visites
- de 22-63 mois: 1 par année

À noter qu'une fois le maximum atteint, le médecin réclame des visites de suivi ou l'intervention clinique, selon la situation.

Tout médecin – Sur RDV ou SRDV

VISITE PONCTUELLE MINEURE

Moins de 500 patients : 15765 - 15767 - 15769 - 15771

Plus de 500 patients : 15766 - 15768 - 15770 - 15772

Évaluation d'un **patient inscrit ou non pour un problème concernant un seul système ou une seule partie du corps**. Inclut questionnaire, l'examen lorsque requis, l'établissement d'un diagnostic et les recommandations.

Peut être répétée plus d'une fois par jour lorsque le contact est requis pour faire un nouveau questionnaire ou examen, pour initier un traitement, évaluer un traitement en cours, observer l'évolution ou la réponse à un traitement.

VISITE PONCTUELLE COMPLEXE

Moins de 500 patients : 15773 - 15775 - 15777 - 15779

Plus de 500 patients : 15774 - 15776 - 15778 - 15780

Évaluation d'un **patient inscrit ou non pour un problème concernant plus d'un système ou plus d'une région du corps**. Inclut questionnaire, l'examen, l'établissement d'un diagnostic et les recommandations.

Peut être facturé plus d'une fois par jour pour un même patient lorsqu'un contact subséquent est requis pour effectuer une nouvelle évaluation physique ou mentale.

Certains types d'examens sont réputés répondre aux exigences :

- l'examen gynécologique incluant l'examen vaginal et l'examen bimanuel incluant, le cas échéant, les prélèvements requis ;
- l'examen ophtalmologique comprenant l'acuité visuelle, l'examen de la cornée et de la chambre antérieure avec la lampe à fente, les champs visuels, l'examen du fond de l'œil et la prise de tension oculaire ;
- l'examen du rachis, de l'épaule, de la hanche ou du genou, lorsque celui-ci comprend l'évaluation de la fonction de l'articulation impliquant la palpation, la mobilisation et les manœuvres diagnostiques utiles ;
- l'évaluation des fonctions mentales supérieures incluant, lorsqu'indiqué, l'évaluation du risque suicidaire.

Tout médecin – RDV ou Accès adapté

VISITE DE PRISE EN CHARGE DE GROSSESSE

Moins de 500 patients : 15805 - 15807 - 15809 - 15825 - 15827 - 15829

Plus de 500 patients : 15806 - 15808 - 15810 - 15826 - 15828 - 15830

S'applique lors de la **première évaluation en vue du suivi prénatal**. Inclut l'examen pertinent, la prescription des examens de dépistage pertinents et, lorsqu'indiqué, le counseling pour cessation tabagique de même que les actes préventifs appropriés. Remplir les formulaires standardisés.

Facturable une seule fois par grossesse. Ne peut être réclamé si le médecin a reçu le supplément pour prise en charge de grossesse au premier trimestre avant.

Bloque la facturation subséquente de visite périodique du patient vulnérable par la suite durant l'année.

Lorsque le médecin qui assure le suivi prénatal transfère la patiente à un deuxième médecin en vue de l'accouchement, du fait que ce premier médecin n'effectue pas d'accouchement, le médecin auquel la patiente est transférée peut facturer la visite de prise en charge de grossesse et, dans ce contexte, il n'est pas tenu de prescrire les examens de dépistage, s'ils ont déjà été effectués.

Lorsque la prise en charge de grossesse a lieu lors du 1^{er} trimestre, 2 types de visites peuvent être facturés :

- une visite de prise en charge durant le 1^{er} trimestre avec référence (transfert) à un autre médecin (codes **15807, 15808, 15827** ou **15828**)
- une visite de prise en charge de grossesse durant le 1^{er} trimestre sans référence à un autre médecin (le médecin assurera le suivi de la patiente durant toute la durée de sa grossesse) (codes **15805, 15806, 15825** ou **15826**)

Lorsque la visite de prise en charge de grossesse a lieu après le 1^{er} trimestre, seule la visite de prise en charge de grossesse au-delà du 1^{er} trimestre peut être facturée, que ce soit après une référence d'un autre médecin (transfert) ou non (codes **15809, 15810, 15829** ou **15830**).

Lorsqu'un médecin fait une prise en charge de grossesse suite à une référence (transfert), vous pouvez indiquer le nom et le numéro de pratique du médecin référent afin d'éviter un refus de votre demande par la RAMQ en cas d'erreur de facturation du 1^{er} médecin (référent).



Plan Élite – Sélectionner « **Dernières menstruations** » dans la case « **Type d'événement** »

Plan Agence – Vous devez fournir la date des dernières menstruations (**DDM**) sur votre castonguette.

VISITE DE SUIVI DE GROSSESSE

Moins de 500 patients : 15811 - 15831

Plus de 500 patients : 15812 - 15832

Évaluation d'une patiente dans le cadre du suivi prénatal. Inclut supplément de suivi de grossesse, questionnaire et examen pertinent, investigations requises et, lorsqu'indiqué, counseling pour cessation tabagique. **Pas de nombre maximal.**

SUPPLÉMENT POUR PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE DE GROSSESSE

Acte 15189

Un supplément pour la prise en charge temporaire et le suivi de grossesse est accordé au médecin qui détient des **privilèges en obstétrique** et assume **temporairement le suivi** d'une patiente enceinte et **fait des accouchements sans devenir son médecin de famille**. Le domicile du patient peut également être reconnu comme lieu de prise en charge et de suivi lorsque le suivi est assuré principalement à domicile.

Ce supplément n'est payable qu'**une seule fois par grossesse** de la patiente et doit être facturé lors de l'examen fait au moment de la prise en charge effective de la grossesse par le second médecin, quel que soit son mode de rémunération (**acte, honoraires fixes ou tarif horaire**).

Le supplément tient lieu d'inscription temporaire et est comptabilisé comme inscription aux fins de la compensation des frais de cabinet.

Le médecin de famille auprès duquel la patiente enceinte est inscrite ne peut pas facturer ces suppléments. Aucun formulaire d'inscription ne doit être rempli par le médecin qui prend en charge temporairement la patiente enceinte. Le supplément doit être facturé à la même date que la visite de prise en charge et sur la même demande de paiement.

Tout médecin sauf médecin traitant sur RDV ou en Accès adapté

VISITE D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE

Acte 9918

Réalisée à la **demande d'un médecin pour obtenir l'opinion du collègue ou sa participation** au suivi en santé mentale en raison de la gravité ou de la complexité du cas. Inclut l'examen psychiatrique, l'examen physique, le plan de traitement et les échanges avec le patient ou les accompagnateurs.

Cette évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, l'examen physique, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel qui l'accompagne.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation psychiatrique produit un rapport écrit de son évaluation et de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il débute.

Par la suite, visite de suivi psychiatrique ou intervention clinique



Plan Élite – Sélectionner « **Professionnel référent** » dans la case « **Type de référent** ». Inscrire le numéro du professionnel dans la case « **Professionnel référent** ». Pour créer un nouveau référent, veuillez vous référer à l'annexe 6.

Plan Agence – Vous devez fournir le numéro du professionnel référent sur votre castonguette.

VISITE DE SUIVI PSYCHIATRIQUE

Acte 8848

Visite auprès de médecin qui **assure suivi conjoint** en santé mentale ou du problème de santé mentale **d'un patient non inscrit**. Inclut le contact avec le patient, et au besoin, l'examen, l'élaboration du plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient ou ses accompagnateurs.

Découle généralement d'une visite d'évaluation psychiatrique.

Du fait de la transition de l'ancienne nomenclature et des services alternatifs facturables (intervention clinique), **le médecin n'aura pas toujours réclamé une visite d'évaluation psychiatrique au préalable.**

Tout médecin sur RDV, Accès adapté ou SRV (patient inscrit ou non)

VISITE D'ÉVALUATION MINEURE

Acte 15789

Réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme pour obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou de la gravité du cas ou de l'expertise du médecin.

Pas facturable si demandé par IPS-PL.

Évaluation de la visite ponctuelle mineure et, au besoin, la révision du dossier, du plan de traitement ou d'investigation, des ordonnances, des recommandations et des échanges courants avec le patient et ses proches. Production d'un rapport écrit de l'évaluation, des recommandations et des investigations ou traitements.



Plan Élite – Sélectionner « **Professionnel référent** » dans la case « **Type de référent** ». Inscrire le numéro du professionnel dans la case « **Professionnel référent** ». Pour créer un nouveau référent, veuillez vous référer à l'annexe 6.

Plan Agence – Vous devez fournir le numéro du professionnel référent sur votre castonguette.

VISITE D'ÉVALUATION COMPLEXE

Acte 15790

Réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme pour obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

Pas facturable si demandé par IPS-PL.

Évaluation physique ou mentale de la visite ponctuelle complexe et, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Production d'un rapport écrit de l'évaluation, des recommandations et des investigations ou traitements.



Plan Élite – Sélectionner « **Professionnel référent** » dans la case « **Type de référent** ». Inscrire le numéro du professionnel dans la case « **Professionnel référent** ». Pour créer un nouveau référent, veuillez vous référer à l'annexe 6.

Plan Agence – Vous devez fournir le numéro du professionnel référent sur votre castonguette.

Précisions sur les visites

VISITES FAITES PAR TÉLÉPHONE OU VISOCONFÉRENCE

TYPE DE VISITE	FACTURABLE	NON FACTURABLE
Visite de prise en charge		X
Visite de suivi	X	
Visite périodique vulnérable	X	
Visite périodique pédiatrique	X	
Visite ponctuelle mineure	X	
Visite ponctuelle complexe	X	
Visite de prise en charge de grossesse		X
Visite de suivi de grossesse	X	
Visite d'évaluation psychiatrique		X
Visite de suivi psychiatrique	X	
Visite d'évaluation mineure	X	
Visite d'évaluation complexe	X	
Psychothérapie	X	
Intervention clinique	X	
Visite à domicile pour patient en perte sévère d'autonomie	X	

*Si examen physique non requis

MÉDECIN TRAITANT ABSENT

Si le médecin traitant est absent pour une période de plus de 13 semaines, il est possible de facturer des visites pour patients inscrits en appliquant le contexte **#MTA13**. Le médecin traitant doit avoir avisé la RAMQ de son absence, et les 2 médecins doivent faire partie du même groupe de pratique à cet établissement. **Les visites périodiques vulnérables et les forfaits annuels GMF ne sont pas facturables.**

Visites facturables (avec contexte #MTA13)	Moins de 500 patients	Plus de 500 patients
Visite de suivi non vulnérable	15803 - 15817	15804 - 15818
Visite de suivi vulnérable	15823 - 15837	15824 - 15838
Visite périodique pédiatrique non vulnérable	15813	15814
Visite périodique pédiatrique vulnérable	15833	15834

Autres actes permis

COMMUNICATIONS AVEC UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

Communications par téléphone avec spécialiste (autre qu'en médecine familiale). Le patient doit être physiquement absent et traité (suivi ou ponctuel) par le médecin qui réclame le service. Discussion requise en raison de la gravité ou de la complexité de la situation et doit viser le plan de traitement pour avoir un avis sur le diagnostic ou des recommandations sur la prise en charge et le suivi **ET le médecin doit compter au moins 500 patients inscrits. Si le médecin a une entente avec le DRMG durant la première année de pratique, lorsqu'il a atteint 250 patients, il peut facturer 7 communications par trimestre.**

	Maximum par trimestre	Code
250 à 499 patients inscrits (Entente DRMG pour la première année de pratique ou plus de 35 ans de pratique)	7	15841
500 à 999 patients inscrits	13	15841
1000 à 1499 patients inscrits	26	15842
1500 patients inscrits ou plus	39	15843

COMMUNICATIONS AVEC D'AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Communication par téléphone avec un autre professionnel (autre que spécialiste ou omnipraticien) concernant un patient dont le médecin assure les soins (suivi ou ponctuel). Le patient est physiquement absent.

Il s'agit d'un professionnel de la santé (**infirmier, travailleur social, inhalothérapeute, diététiste ou pharmacien exclusivement**) qui ne fait pas partie du personnel du cabinet ou de l'installation et avec lequel le professionnel échange couramment. La discussion concerne les soins à prodiguer au patient.

Si la communication est avec un pharmacien, elle doit donner lieu à un changement thérapeutique (à l'exclusion de l'ordonnance téléphonique ou d'un renouvellement) **ET le médecin doit compter au moins 500 patients inscrits. Si le médecin a une entente avec le DRMG durant la première année de pratique, lorsqu'il a atteint 250 patients, il peut facturer 7 communications par trimestre.**

	Maximum par trimestre	Code
250 à 499 patients inscrits (Entente DRMG pour la première année de pratique ou plus de 35 ans de pratique)	7	15844
500 à 999 patients inscrits	13	15844
1000 à 1499 patients inscrits	26	15845
1500 patients inscrits ou plus	39	15846

À noter que la demande de paiement doit faire état de l'identité du patient (NAM) et du lieu où la communication est effectuée. De plus, le nom et le numéro de pratique sont OBLIGATOIRES.

TÉLÉDERMATOLOGIE - CONSULTATIONS VIRTUELLES EN TEMPS DIFFÉRÉ

Sans égard à son milieu de pratique, le médecin qui complète et transmet la documentation requise pour faire une demande de consultation virtuelle sécurisée en temps différé (asynchrone) par le biais de la plateforme de soins virtuels désignée par le MSSS prévue pour la télédermatologie et pour la gestion de la douleur chronique pour un patient dont il assure les soins peut se prévaloir d'un montant forfaitaire.

Lorsque le temps requis pour compléter et transmettre la demande pour un même patient excède 15 minutes, le médecin se prévaut de deux montants forfaitaires.

Dans tous les cas, la demande de paiement doit faire état de l'identification du patient et du lieu de son hébergement ou de son admission ou, lorsque le patient n'est pas hébergé ou admis, du lieu à partir duquel la demande a été transmise.

Le **médecin-répondant** est un médecin de famille détenant une expertise spécifique dans un secteur d'activités et qui répond par écrit à une demande de conseil d'un médecin de famille ou d'une IPS via la plateforme web sécurisée autorisée par le MSSS pour le conseil numérique, et ce, afin de transmettre son opinion au sujet du diagnostic, du suivi ou du traitement d'un patient.

Le conseil du médecin-répondant comprend :

- La prise en charge de la demande de conseil ;
- La recherche nécessaire pour répondre à la demande, le cas échéant ;
- Les demandes d'information complémentaire au médecin ou à l'IPS le cas échéant ;
- La rédaction de la réponse dans la plateforme web sécurisée autorisée par le MSSS pour le conseil numérique.

Le médecin-répondant est rémunéré selon un montant forfaitaire par conseil numérique, et ce, sans égard au nombre de questions incluses à la demande.

15895

Télédermatologie

À noter que la demande de paiement doit faire état de l'identité du patient (NAM), du lieu et de l'heure où la communication est effectuée.

CONSEIL NUMÉRIQUE (eConsult)

De plus, en faisant les adaptations nécessaires, le médecin peut également se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l'alinéa qui précède lorsque celui-ci communique avec le médecin spécialiste (à l'exclusion d'un spécialiste en médecine de famille) via la plateforme web sécurisée prévue pour le conseil numérique (eConsult). Les modalités d'utilisation de cette plateforme sont celles définies par le MSSS. Aux fins de l'application du présent paragraphe, ce code s'applique sans égard au nombre minimum de patients inscrits requis par ce code et sans y appliquer le nombre maximal de montants forfaitaires par trimestre. De plus, lorsque l'acte de communication par conseil numérique (eConsult) dépasse une durée de quinze (15) minutes, le médecin réclame deux codes d'acte.

15894

Conseil numérique (eConsult) par période de 15 minutes

15898

Médecin-répondant

La durée en minutes ainsi que l'heure de début et de fin sont OBLIGATOIRES.



Plan Élite – utiliser le type **PATIENT**

EXAMEN D'ÉVALUATION MÉDICALE (CTMSP)

L'examen d'évaluation médicale d'un patient en perte d'autonomie en vue d'allocations de ressources et la rédaction du formulaire approprié sont constitués des éléments suivants :

- Le questionnaire portant sur :
 - les antécédents familiaux du patient ;
 - les antécédents personnels du patient ;
 - la problématique présentée par le patient ;
 - une prise de connaissance de la situation socio-économique ;
 - la revue de la médication et des habitudes de vie ;
 - le fonctionnement des ensembles et systèmes suivants :
 - nez, gorge, oreilles ;
 - système cardio-vasculaire ;
 - système nerveux ;
 - yeux ;
 - système respiratoire ;
 - appareil locomoteur ;
 - système digestif ;
 - système génito-urinaire ;
 - système endocrinien.
- Le bilan sommaire des capacités fonctionnelles.
- L'évaluation sommaire des sphères de la pensée, de l'affectivité, du comportement et des fonctions mentales supérieures.
- L'examen clinique des régions suivantes :
 - peau ;
 - tête ;
 - organes génitaux (sauf contre-indication) ;
 - phanères ;
 - cou ;
 - abdomen ;
 - ganglions ;
 - thorax ;
 - colonne et extrémités.
- La consignation au dossier des données significatives que le médecin juge pertinentes.
- La recommandation au patient, aux proches ou à la personne responsable en ce qui concerne le bilan de l'évolution et le degré de perte d'autonomie du patient.
- La rédaction, et son envoi à l'organisme concerné, du formulaire contenant les recommandations du médecin portant notamment sur :
 - le bilan médical et le pronostic ;
 - le degré de perte d'autonomie du patient ;
 - les suggestions d'allocation de services.

9100

Examen d'évaluation médicale d'un patient en perte d'autonomie en vue d'allocations de ressources et en vue de la rédaction du formulaire approprié.

9101

Rédaction du formulaire

9063

Supplément lorsqu'effectué à domicile

INTERVENTION CLINIQUE

Intervention clinique individuelle - raccourci I

L'intervention clinique est, en termes de contenu clinique, équivalente à un examen ou à une consultation, mais elle est d'une durée plus longue pour des raisons diverses, que ce soit, par exemple, à cause de l'importance du conseil, du soutien ou de l'information à transmettre au patient et, selon le cas, à ses proches, ou encore parce que la communication avec le patient doit se faire par l'intermédiaire d'un interprète ou d'un accompagnateur.

Durée réelle	Durée à facturer
25 à 37 min	30 min
38 à 52 min	45 min
53 à 67 min	60 min
68 à 82 min	75 min
83 à 97 min	90 min
Etc.	

Pour donner droit à la rémunération prévue pour l'intervention clinique, la séance doit être d'au moins **25 minutes**. À compter de 30 minutes, une ou des **périodes supplémentaires de 15 minutes** peuvent être facturées. Pour avoir droit à la dernière période de 15 minutes, vous devez avoir rendu des services pendant un **minimum de 8 minutes**. Le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon **ininterrompue. Maximum 180 minutes dans la journée, tous lieux confondus.**



Plan Élite – vous avez 2 façons d'indiquer l'information pour la saisie :

1. Raccourci I + durée et inscrire l'heure de début exacte. **Ex : I38 à 14h**
2. Heure de début – heure de fin de l'intervention. **Ex : I1400-1438**

Selon le contexte, certaines interventions cliniques ne sont pas comptabilisées pour les fins du plafond (maximum de 180 minutes), une précision doit être inscrite sur la demande de paiement (**#élément de contexte**) :

- pour un problème de santé mentale (**#ICSM**)
- pour un problème de toxicomanie (**#ICTOX**)
- auprès d'une personne présentant les caractéristiques d'une des catégories de problèmes de santé (par. 5.01 de l'Entente particulière de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle), (**#ICEP**) ***s'ajoute automatiquement lorsque 15169 est facturé avec l'intervention clinique***
- pour un patient GAP inscrit collectivement (**#GAP**)

Chevauchement : Lorsque la dernière période supplémentaire est d'au moins 8 minutes, une intervention clinique subséquente effectuée auprès d'un autre patient ne peut être facturée avant que le délai de 15 minutes de la dernière période supplémentaire de la précédente intervention ne soit écoulé. La dernière période supplémentaire doit avoir une durée minimale de 8 minutes pour qu'elle soit rémunérée selon le tarif prévu pour une période complète de 15 minutes.

Toutefois, il vous est possible de réclamer 2 interventions cliniques qui se chevauchent lorsqu'un résident a vu le patient et que vous avez participé à une partie des services. Les deux interventions cliniques ne doivent pas débiter à la même heure.

Le temps réel du résident pour chaque visite doit être considéré.

La limitation du non-chevauchement concerne seulement l'intervention clinique lorsqu'elle est successive. Vous pourriez facturer une visite pour un patient suivant alors que l'intervention clinique est terminée, mais toujours rémunérée. Par exemple, une intervention clinique de 55 minutes est facturée de 11h00 à 11h55, mais rémunérée jusqu'à 12h00 (60 minutes) vous permettrait de voir un patient débutant à 11h57 pour lequel vous factureriez une visite de suivi. Cet acte inclut, à la même séance et pour le même patient, l'examen, la consultation, les activités cliniques préventives, la psychothérapie ou tout autre acte sauf le plateau de chirurgie.

FACNET

Plan Élite – Vous devez indiquer dans la case « résident qui a vu le patient » le numéro du résident. (La lettre « R » est remplacée par le chiffre 5 (5XXXXX)).

Les actes de CNESST ou autres formulaires facturables à la RAMQ doivent être exclus du temps comptabilisé comme intervention clinique individuelle.
L'heure exacte du début de l'intervention clinique est OBLIGATOIRE.

8857	Individuelle – 30 premières minutes
8859	15 minutes supplémentaires
8861	Domicile par période 15 minutes – requiert l'heure de début et de fin entre chaque domicile

Codes d'actes que vous pouvez facturer avec une intervention clinique individuelle

Code	Description
*1098, 1099,1100	Les plateaux, supplément d'honoraires prévu, par séance, à titre de frais compensatoires, pour certains actes nécessitant l'utilisation d'un plateau de chirurgie. ○ (P.G. 2.4.7.7 A) = plateau principal = code 1098 ○ (P.G. 2.4.7.7 B) = plateau mineur = code 1099 * Les actes chirurgicaux ne sont pas facturables avec l'intervention clinique, mais la compensation pour le plateau est permise. ○ (P.G. 2.4.7.7 C) = plateau pour services d'avortement thérapeutique = code 1100
8875	Le forfait de prise en charge et de suivi du patient inscrit en GMF est facturé une fois par année civile (1er janvier au 31 décembre) par GMF et par patient, lors de la première visite annuelle du patient au GMF. Le forfait doit être ajouté à la rémunération du médecin pour chacun de ses patients inscrits.
8877	Le médecin qui fait un examen périodique auprès d'un enfant âgé de 0 à 5 ans qu'il a inscrit à son nom. Le forfait est facturable lorsque l'intervention clinique répond aux exigences de l'ABCdaire de suivi des jeunes enfants, des examens qui visent à dépister les problèmes de croissance, de développement ou des problèmes particuliers qui peuvent apparaître en bas âge. Le nombre d'examens périodiques admissibles au supplément prévu au présent paragraphe se répartit comme suit : ○ de 0-21 mois : 8 visites ○ de 22-63 mois: 1 par année Le patient doit être inscrit au nom du médecin traitant. Ce supplément est inclus dans le nombre de visites périodiques pédiatriques réclamé.
15144	Un supplément s'ajoute lorsque l'intervention clinique est faite dans le cadre d'un suivi de grossesse. Il peut être facturé même si le médecin ne détient pas de privilèges en obstétrique. Lorsque le médecin ne prévoit pas d'effectuer lui-même l'accouchement de la patiente enceinte, une entente doit avoir été conclue avec un autre médecin qui exerce en obstétrique afin d'assurer le suivi lorsque requis ainsi que l'accouchement de la patiente. Incompatible avec le supplément à l'examen de prise en charge de grossesse 15159.

	Supplément à l'examen de prise en charge de grossesse (acte 59) est accordé lorsque cet examen est fait au cours du premier trimestre (13 premières semaines de grossesse) de la grossesse de la patiente. Se facture lors de la prise en charge de grossesse sur la même demande que l'intervention clinique. La date des dernières menstruations (DDM) est OBLIGATOIRE. Ce supplément peut être facturé même si le médecin ne détient pas de privilèges en obstétrique. Lorsque le médecin ne prévoit pas d'effectuer lui-même l'accouchement de la patiente enceinte, une entente doit avoir été conclue avec un autre médecin qui exerce en obstétrique afin d'assurer le suivi lorsque requis ainsi que l'accouchement de la patiente. Ce supplément n'est payable qu'une seule fois par patiente. Dans le cas où un médecin recommande une patiente à un second médecin au cours du premier trimestre de sa grossesse pour en assurer le suivi, le supplément est payable au médecin auquel la patiente a été recommandée. Dans le cas où un médecin recommande une patiente à un second médecin, ou dans le cas d'un transfert, ce dernier doit inscrire le prénom et le nom au complet du médecin référent dans la case RÉFÉRENT.
15159 15169 (en cabinet) 15171 (à domicile)	Partage du forfait de responsabilité : le forfait peut être payé à un autre médecin que celui auprès duquel le patient est inscrit aux conditions : ○ un groupe de pratique est formé au site de pratique en remplissant le formulaire 4060 et en le faisant parvenir à la Régie par télécopieur ou par la poste ; ○ le médecin fait partie du même groupe de pratique que celui qui a inscrit le patient ; ○ les médecins du groupe consentent à ce que le forfait puisse être facturé par tout médecin du groupe. Ne peut être facturé avec une visite. S'applique avec l'intervention clinique ou la psychothérapie seulement.
19957	Supplément pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille non vulnérable.
19958	Suppléments pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille vulnérable non référé
19959	Suppléments pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille vulnérable référé
19960	Suppléments pour la prise en charge d'un patient sans médecin de famille TRÈS vulnérable référé (code 1+11 OU 11+20 OU 6)

	Supplément pour la prise en charge temporaire et le suivi de grossesse est accordé au médecin qui détient des privilèges en obstétrique et assume temporairement le suivi d'une patiente enceinte et fait des accouchements sans devenir son médecin de famille. Le domicile du patient peut également être reconnu comme lieu de prise en charge et de suivi lorsque le suivi est assuré principalement à domicile.
15189	Ce supplément n'est payable qu'une seule fois par grossesse de la patiente et doit être facturé lors de l'examen fait au moment de la prise en charge effective de la grossesse par le second médecin, quel que soit son mode de rémunération (acte, honoraires fixes ou tarif horaire). Le supplément tient lieu d'inscription temporaire et est comptabilisé comme inscription aux fins de la compensation des frais de cabinet. Le médecin de famille auprès duquel la patiente enceinte est inscrite ne peut pas facturer ces suppléments. Aucun formulaire d'inscription ne doit être rempli par le médecin qui prend en charge temporairement la patiente enceinte.
19074	Le forfait s'applique au médecin qui, dans le cadre de sa pratique en obstétrique, assume temporairement le suivi d'une patiente inscrite auprès d'un autre médecin du même GMF. Le médecin doit détenir des privilèges en obstétrique. Payable une fois par grossesse lors de l'examen de prise en charge de grossesse.
13, 14, 15234	Constat de décès
15265	Rédaction du bulletin de décès (SP-3)
Formulaires	CNESST, IVAC, 9800, 9817, 9825, 9826

Le médecin qui consacre plus de vingt-cinq (25) minutes à la rencontre avec son patient peut être rémunéré, à son choix, à l'acte au tarif de la visite ou de la consultation, ou selon les présentes dispositions relatives à l'intervention clinique.

Si le médecin qui exerce en cabinet doit se **déplacer à domicile**, un supplément (**code d'acte 08861**) de **27,40\$ par période de 15 minutes** est payable pour son déplacement au-delà des **dix premiers kilomètres** des limites de la ville ou du village où il exerce. **Un maximum de six périodes est permis pour l'aller-retour. Donc, 45 minutes pour l'aller et 45 minutes pour le retour.**

8861	Supplément pour se déplacer à domicile par période de 15 minutes
------	--

Intervention clinique collective - raccourci IC

Lorsqu'elle est dispensée à plus d'une (1) personne au cours de la même séance.

Conditions :

- la séance doit être d'au moins 25 minutes ;
- à compter de 30 minutes, une ou des périodes supplémentaires de 15 minutes peuvent être facturées. Pour avoir droit à la dernière période de 15 minutes, vous devez avoir rendu des services pendant un minimum de 8 minutes ;
- le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon ininterrompue ;
- maximum 180 minutes tous lieux confondus.

Chevauchement : Lorsque la dernière période supplémentaire est d'au moins 8 minutes, une intervention clinique subséquente effectuée auprès d'un autre patient ne peut être facturée avant que le délai de 15 minutes de la dernière période supplémentaire de la précédente intervention ne soit écoulé. La dernière période supplémentaire doit avoir une durée minimale de 8 minutes pour qu'elle soit rémunérée selon le tarif prévu pour une période complète de 15 minutes. **Toutefois, il vous est possible de réclamer 2 interventions cliniques qui se chevauchent lorsqu'un résident a vu le patient et que vous avez participé à une partie des services.**

L'heure exacte du début de l'intervention clinique est OBLIGATOIRE.



Plan Élite – Vous devez indiquer dans la case « résident qui a vu le patient » le numéro du résident. (La lettre « R » est remplacée par le chiffre 5. (5XXXXX))

Toutefois, l'intervention clinique collective **ne permet pas de réclamer des suppléments** (voir tableau d'une intervention clinique individuelle).

8866	Collective – 30 premières minutes
-------------	-----------------------------------

8868	15 minutes supplémentaires
-------------	----------------------------

PSYCHOTHÉRAPIE - raccourci Y (nécessite des privilèges)

La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien.

Le médecin doit respecter les quatre règles prévues pour que le service soit conforme :

- établir un processus interactionnel structuré avec le client ;
- procéder à une évaluation initiale rigoureuse ;
- appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication ;
- s'appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes d'intervention validées qui respectent la dignité humaine.

La durée minimale de la psychothérapie est de **25 minutes**. À compter de 30 minutes, une ou des **périodes supplémentaires de 15 minutes** peuvent être facturées. Le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon **ininterrompue. Ne dépasse généralement pas 90 minutes**.

Donc, si avec le total de vos minutes, vous avez commencé une période supplémentaire, vous arrondissez le total des minutes. Exemple : si le total de vos minutes donne 35 minutes, vous arrondissez à 45 minutes. Si vous faites une psychothérapie de 50 minutes, vous inscrivez Y60.

Ce service inclut à la même séance l'examen, la consultation, les activités cliniques préventives, l'intervention clinique ou tout autre acte.

15785	Psychothérapie – 30 premières minutes
--------------	---------------------------------------

15786	15 minutes supplémentaires
--------------	----------------------------

Codes d'actes que vous pouvez facturer avec une psychothérapie

Code	Description
	Forfait clientèle vulnérable
15169, 15171	Partage du forfait de responsabilité : le forfait peut être payé à un autre médecin que celui auprès duquel le patient est inscrit aux conditions : ○ un groupe de pratique est formé au site de pratique en remplissant le formulaire 4060 et en le faisant parvenir à la Régie par télécopieur ou par la poste ; ○ le médecin fait partie du même groupe de pratique que celui qui a inscrit le patient ; ○ les médecins du groupe consentent à ce que le forfait puisse être facturé par tout médecin du groupe. Ne peut être facturé avec une visite. S'applique avec l'intervention clinique ou la psychothérapie seulement.
8875	Le forfait de prise en charge et de suivi du patient inscrit en GMF est facturé une fois par année civile (1er janvier au 31 décembre) par GMF et par patient, lors de la première visite annuelle du patient au GMF. Le forfait s'ajoute à la rémunération du médecin pour chacun de ses patients inscrits.
Tous	Formulaire de CNESST, IVAC
9982	Bureau d'évaluation médicale en raison de la complexité

PATIENT ABSENT – raccourci NSPP

Un code d'acte, dont le tarif associé est fixé à 0 \$, utilisé par la Régie à des fins statistiques exclusivement.

Le médecin peut facturer ce code d'acte lorsqu'un patient, inscrit ou non, ne se présente pas à une visite prévue en rendez-vous ou en sans rendez-vous.

9956

Le patient ne s'est pas présenté

Visites à domicile

Les codes de visites à domicile spécifiques ne peuvent s'appliquer que pour des patients en perte sévère d'autonomie. En dehors des visites de PSA, le médecin réclame des visites régulières en ajoutant l'élément de contexte #VDOM. Veuillez vous référer à la section VISITE au début du guide pour connaître la nomenclature applicable.

Frais de kilométrage si plus de 10 km du lieu principal de pratique du médecin. Si vous facturez le kilométrage, les 10 premiers km doivent être déduits du total.

Vous devez nous fournir l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le code postal de votre lieu de départ, du lieu d'arrivée et ce, tant pour l'aller que le retour.

VISITE À DOMICILE AUPRÈS D'UN PATIENT EN PERTE SÉVÈRE D'AUTONOMIE

Visite à domicile au Québec d'évaluation initiale ou de suivi.

L'évaluation initiale ou annuelle inclut l'examen subjectif de perte d'autonomie, l'évaluation physique ou mentale, l'évaluation fonctionnelle, la liste des problèmes médicaux actifs et le plan d'intervention médicale. Lors de visites subséquentes, doit prodiguer des soins courants à la suite d'un examen physique ou mental pour initier un traitement, évaluer un traitement en cours ou suivre l'évolution d'une maladie.

Le patient doit:

- Avoir besoin de soins médicaux actifs ;
- Être incapable de sortir de chez lui sans déployer d'efforts importants, s'exposer à un risque élevé ou sans supervision continue d'un tiers ;

OU

- Être en soins palliatifs et faire l'objet de visites à domicile, et aussi pour un médecin dans le cadre de ses fonctions au sein d'un service en gériatrie.

Le tarif peut être réclamé pour jusqu'à trois (3) patients en perte sévère d'autonomie sous un même toit.

Le médecin peut toujours opter pour une autre visite (prise en charge) ou l'intervention clinique.

Frais de kilométrage si plus de 10 km du lieu principal de pratique du médecin. Lors d'un déplacement d'urgence, le médecin peut réclamer un supplément de déplacement 24/7. Le tarif est modulé selon la plage du déplacement : 7h-16h, 16h-24h, 0h-7h. **Vous devez nous fournir l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le code postal de votre lieu de départ, du lieu d'arrivée et ce pour l'aller ainsi que le retour.**

Visite à domicile patient en perte sévère d'autonomie	Durée	Patient non vulnérable	Patient vulnérable
1er patient		15781	15783
Patient additionnel sous le même toit (2 ^e et 3 ^e patients)		15782	15784
Intervention clinique	30 minutes	8857	
Lorsqu'utilisée pour une visite à domicile (perte sévère d'autonomie ou non), il y a une adaptation lorsque le déplacement unidirectionnel est de plus de 10 kilomètres.	15 minutes supp.	8859	
Déplacement lors d'une intervention clinique			
En plus de la compensation pour kilométrage, le médecin peut se prévaloir du temps de déplacement unidirectionnel après 10 km jusqu'à concurrence de 45 minutes dans chaque direction.	Par période de 15 minutes	8861	
Toutes visites pour patient inscrit ou non		Ajouter le contexte #VDOM	

Autres précisions

Pour les raccourcis clavier, ainsi que la liste des éléments de contexte détaillés, veuillez vous référer à la liste sur l'aide en ligne ou au document transmis par votre conseiller en facturation.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Raccourcis	Code RAMQ	Détails	Où le mettre ?
SI93	1650	Site anatomique différent	Sur le second acte qui concerne un site anatomique différent.
SD94	85	Séance différente	Si plusieurs visites, examens ou interventions cliniques sont facturés pour un même patient, le même jour et dans un même lieu, #SD94 doit être appliqué sur toutes les visites, interventions cliniques ou examens subséquents. Sur le ou les actes effectués à une séance différente du premier acte
ICEP	1714	Intervention clinique effectuée pour un problème de santé figurant à l'EP - Médecine de famille, prise en charge, suivi de la clientèle (par. 5.01)	L'acte d'intervention clinique (s'ajoute automatiquement sur IC si 15169 facturé)
ICSM	1715	Intervention clinique effectuée pour un problème de santé mentale	L'acte d'intervention clinique
ICTOX	1716	Intervention clinique effectuée pour un problème de toxicomanie	L'acte d'intervention clinique
G160	310	Pendant une période de SRV en GMF	Sur les frais de cabinet (19928 - 19929) et demandes de patients
AR	1911	Sans rendez-vous d'un GMF-R (EP 54)	Sur les frais de cabinet (19928 - 19929) et demandes de patients
VDOM	1711	Si un patient vu à domicile n'est pas en perte sévère d'autonomie, alors il faut facturer la visite (exemple : visite de suivi) avec cet élément de contexte	Sur les demandes de patients

MTA13	1712	Médecin traitant absent pour plus de 13 semaines consécutives (maternité ou invalidité)	Sur les visites de patients inscrits (visite de suivi ou visite périodique pédiatrique)
CHIR	710	Lorsque plusieurs chirurgies sont faites au cours de la même séance, alors seule la plus avantageuse est payée à 100 %	Sur le ou les actes chirurgicaux facturés en plus d'un premier acte chirurgical le même jour
ADT	870	Lorsque plusieurs actes diagnostiques sont faits à la même séance, alors seule la plus avantageuse est payée à 100 %	Sur le ou les actes diagnostiques facturés en plus d'un premier acte diagnostique à la même séance
TT	1840	Consultation par voie téléphonique	Sur le ou les actes facturés en contexte de consultation faite par téléphone.
TV	1839	Consultation par visioconférence	Sur le ou les actes facturés en contexte de consultation faite par visioconférence.

PLAGE Horaire

Plage	Début	Fin
Nuit	0h	8 h
AM/PM	8 h	18 h
Soir	18 h	22 h

SYMBOLES POUR LES UTILISATEURS DU PLAN ÉLITE

Symbole	Description	Exemple
#	Élément de contexte	EX : VS#SD94
:	Unités	EX : 1323:3

MAJORATION APPLICABLE À L'ACTE

Période	Heure	Majoration (%)
Lundi, mardi, mercredi ou jeudi	18 h à 22 h	16
Vendredi	18 h à 22 h	26
Samedi, dimanche ou journée fériée	8 h à 24 h	26
Samedi, dimanche ou journée fériée (sans rendez-vous d'une clinique-réseau)	8 h à 24 h	33

Vous devez spécifier sur la demande de paiement les heures de début pour chaque visite afin d'obtenir la majoration applicable.

Déplacement d'urgence

DÉPLACEMENT D'URGENCE DE NUIT

De 0 h à 7 h, un médecin qui, à la suite d'un appel d'urgence, doit se rendre auprès d'un patient, à domicile ou en établissement, est rémunéré :

- selon la rémunération à l'acte ;
- OU
- selon un tarif global pour l'ensemble des soins dispensés à ce patient.

Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement.

9099	Déplacement d'urgence de nuit de 0 h à 7 h uniquement
-------------	---



Plan Élite – utiliser le NAM patient

SUPPLÉMENT D'HONORAIRE POUR DÉPLACEMENT D'URGENCE À DOMICILE, EN CABINET

Ce supplément d'honoraires s'applique uniquement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins prodigués à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans le supplément de déplacement.

15847	7 h à 16 h
15848	16 h à 24 h
15849	0 h à 7 h



Plan Élite – utiliser le NAM patient, utiliser le raccourci DU avec la bonne heure et le bon code se facturera.

Actes courants

PATIENT SANS MÉDECIN DE FAMILLE

Le médecin qui accepte d'inscrire, de prendre en charge et de suivre un patient vulnérable ou non vulnérable et sans médecin de famille, sur référence ou non du guichet du GAMF, a droit à un montant supplémentaire qui sera versé en **un seul versement** à l'inscription du patient à l'occasion d'un examen ou d'une intervention clinique.

19957	Lorsque le patient est sans médecin de famille, non vulnérable, qu'il soit priorisé ou non et référé ou non par le GAMF
19958	Lorsque le patient est sans médecin de famille vulnérable, non priorisé et non référé par le GAMF
19959	Lorsque le patient est sans médecin de famille vulnérable, priorisé et référé par le GAMF
*19960	Lorsque le patient est sans médecin de famille, très vulnérable, priorisé et référé par le GAMF et répondant à certaines conditions de vulnérabilité catégorie 1 et 11 ou 20 et 11 ou 6

*Vous aurez à utiliser le code **19960** au lieu de **19959** (priorisé, référé et vulnérable) si vous avez un patient référé par le guichet qui aurait comme problème de santé (**01**) problème de santé mentale ET (**11**) troubles dépressifs majeurs récidivants (les deux codes) OU (**20**) problème de santé (DSM-IV) ET (**11**) troubles dépressifs majeurs récidivants (les deux codes) OU (**06**) toxicomanie ou alcoolisme.

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l'examen ou l'intervention clinique.

Le médecin peut inscrire un maximum de 150 patients, vulnérables ou non, référés par le GAMF ou par transfert en bloc par année civile. Vous avez **60 jours** pour inscrire un patient provenant du GAMF, à l'exception des médecins participant à la lettre d'Entente 321 (bloc de patient).



Plan Élite – utiliser le NAM patient

IMPLANT CONTRACEPTIF SOUS-CUTANÉ

Implant sous-cutané de type Nexplanon ou autre.

	Code
Un seul implant	6980
Plus d'un implant à la même séance	6981
Exérèse d'un implant contraceptif sous-cutané	6982
Exérèse de plus d'un implant à la même séance	6983

COMMUNICATION À L'AIDE D'UN INTERPRÈTE

Lorsque la communication entre le patient et le médecin ne peut se faire **en français ou en anglais** et que celle-ci exige l'intervention d'un interprète. **Pas besoin d'un interprète officiel, un membre de la famille, ami ou autre est accepté. Il doit simplement s'agir d'une vraie personne (les outils de traduction comme Google Traduction ne comptent pas pour facturer ce supplément).** Il peut être réclamé lors de chaque visite faite auprès du patient.

Ne peut être réclamé avec les codes d'acte relatifs à l'intervention clinique et lors de la psychothérapie. Pas facturable pour un médecin payé à tarif horaire ou à honoraires fixes.

15188 Supplément communication avec l'aide d'un interprète



Plan Élite – utiliser le NAM patient

L'INTERVENTION PRÉVENTIVE RELATIVE AUX INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS)

L'intervention préventive relative aux ITSS a pour objet la cueillette de renseignements permettant l'évaluation du niveau de risque d'ITSS chez une personne symptomatique ou asymptomatique et les actions spécifiques de nature préventive appropriées selon le niveau de risque décelé, dont :

- le counseling pré-test ;
- l'évaluation des indications de dépistage et d'immunisation ;
- la détection d'ITSS par analyse de biologie médicale à des fins de dépistage et de diagnostic, le cas échéant ;
- l'interprétation des résultats des analyses et l'établissement du diagnostic ;
- la communication des résultats d'analyse ;
- la prescription du traitement approprié et l'intervention préventive visant la notification des partenaires ;
- le counseling post-test, que les résultats soient positifs ou négatifs ;
- l'orientation de la personne atteinte pour un suivi médical ou psychosocial.

Cette intervention peut être facturée lorsqu'elle est faite en cabinet. Elle nécessite généralement plus d'une visite.

Remplir et acheminer à la Direction de santé publique le formulaire de déclaration obligatoire lorsque requis par la *Loi sur la santé publique* est inclus dans l'intervention préventive.

Le médecin peut facturer l'intervention préventive relative aux ITSS autant à la première visite qu'au cours des visites subséquentes. Il peut la facturer seule ou à l'occasion d'un examen effectué auprès du patient. La durée de cette intervention est d'au moins quinze (15) minutes au-delà du temps consacré à l'examen s'il est indiqué.

Au cours de la même visite, le médecin ne peut facturer l'intervention clinique et la psychothérapie.

15230

Intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), par bloc complet de 15 minutes (ex. : 15230:15 = 15 minutes)

PLATEAUX DE CHIRURGIE

Un supplément d'honoraires est prévu, **par séance**, à titre de frais compensatoires, pour certains actes nécessitant l'utilisation d'un plateau de chirurgie.

1098	Plateau principal 2.4.7.7. A
1099	Plateau mineur 2.4.7.7. B
1100	Plateau mineur 2.4.7.7. C (avortement thérapeutique)



Plan Élite – le plateau s’ajoute automatiquement lorsqu’un acte nécessitant l’utilisation du plateau est facturé, sauf avec l’intervention clinique si l’acte prérequis est absent.

ACTES NON TARIFIÉS (9990)

Certains actes ne sont pas tarifés dans votre entente de rémunération parce qu’ils n’ont pas encore été négociés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et votre fédération. Toutefois, ils peuvent être considérés comme des services couverts s’ils sont requis pour des raisons médicales. Un code de référence pour situations spéciales (CRSS) correspond alors au service non tarifé facturé.

Acte à facturer	Code CRSS
Formulaire relatif à la demande anticipée d’aide médicale à mourir	5176
Remplissage du formulaire de la SAAQ en lien avec l’article 22 a) ii du RALAM (permis de conduire)	5167
Infiltration par voie transcutanée, sous guidage échoscopique, dans l’articulation coxo-fémorale ou sacro-iliaque	5109
Infiltration par voie transcutanée, sous guidage échoscopique	5107

Pour facturer cet acte, **il est important que ce dernier soit le seul de sa facture**. Si vous voulez facturer une visite, il faudra créer deux demandes différentes.

Pour facturer cet acte, vous devez indiquer le code CRSS en guise d’unité. Par exemple, si vous souhaitez facturer le formulaire SAAQ, il faudra inscrire « 9990:5167 ».

TARIF HORAIRE - ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT EN GMF

Par le biais d'une banque d'heures répartie entre les médecins par le responsable du GMF, le temps que le médecin consacre aux activités professionnelles requises par le fonctionnement en GMF est rémunéré à tarif horaire. Ces activités comprennent notamment les activités de coordination et de suivi en GMF, les activités interdisciplinaires, les activités de concertation avec les autres intervenants du milieu et, enfin, les activités médico-administratives et de formation reliées au fonctionnement en GMF.

Lors d'un **congé** ou d'une **absence**, le médecin **ne peut facturer** les heures qui lui sont allouées en activités de fonctionnement.

La banque d'heures du GMF est déterminée sur la base de trois heures par semaine par médecin équivalent temps plein. Cependant, il est de la responsabilité du médecin responsable de répartir les heures allouées entre les médecins selon des critères qu'il a établis. Le formulaire doit être imprimé et signé par le signataire autorisé et conservé jusqu'à 5 ans aux fins de vérifications par la RAMQ.

Les heures facturées doivent correspondre à des activités réelles effectuées au sein de l'établissement.

72101 Activités de fonctionnement en GMF

Taux horaire : **99,48 \$**

Le formulaire doit être signé par vous et le signataire de votre établissement et conservé pour une période de 5 ans.



Plan Élite – veuillez-vous référer à l'ANNEXE 5 pour suivre la procédure de facturation

Frais de cabinet

GÉNÉRALITÉS

Selon le type de cabinet (GMF, réseau, GMF-R ou hors GMF), les règles d'application pour la facturation des frais de cabinet sont différentes. Vous retrouverez plus bas par type ces normes d'application.

Pour tous les types sauf les cabinets hors GMF, lorsque dans la même journée un médecin dispense à la fois des services sur rendez-vous (plage de rendez-vous) et sans rendez-vous (plage de sans rendez-vous), l'atteinte du seuil pour chaque type d'activité **s'évalue distinctement** en tenant compte du type de clientèle et du nombre minimum de patients requis pour chacun de ces secteurs sans permettre le dépassement du **maximum quotidien permis de 64,20 \$ (2 forfaits 19928 ou 1 seul forfait 19929 maximum)**.

Les « patients inscrits » correspondent aux patients inscrits par le médecin lui-même et/ou ceux inscrits auprès d'un médecin de son groupe de pratique (lorsqu'il y en a un dans son cabinet).

Exemples :

1. Un médecin dans un cabinet GMF voit 6 patients inscrits le matin dans une plage de rendez-vous et voit 10 patients l'après-midi dans une plage de sans rendez-vous.
Il peut se prévaloir de deux forfaits 19928 de 32,10 \$, un pour les patients inscrits et vus dans la plage de rendez-vous et un pour les patients vus dans la plage de sans rendez-vous.
2. Un médecin dans un cabinet GMF voit 12 patients inscrits le matin dans une plage de rendez-vous et voit 10 patients l'après-midi dans une plage de sans rendez-vous.
Il ne peut se prévaloir que du forfait 19929 de 64,20 \$, ou de deux forfaits 19928 de 32,10 \$. Il ne peut cumuler le forfait 19929 applicable pour les 12 patients inscrits vus dans la plage de rendez-vous, et le forfait 19928 éventuellement applicable pour les 10 patients vus dans la plage de sans rendez-vous.

RAPPEL DE LA DÉFINITION DE « PLAGE DE SERVICES SANS RENDEZ-VOUS » (Préambule général)

La « plage de services sans rendez-vous » est définie comme étant « toute période au sein d'un milieu de première ligne durant laquelle un médecin est affecté à répondre aux besoins à court terme autant de ses patients que des patients inscrits auprès de ses collègues ou d'autres médecins, ou des patients sans médecin de famille ». Ce rappel de définition vise à éviter qu'une pratique en accès adapté soit par erreur traitée comme des plages de services sans rendez-vous.

Des marqueurs de services, aussi appelés indicateurs, ont été définis par la RAMQ en date du 1^{er} août 2021 afin de permettre de déterminer si votre service est rendu dans une plage de services sans rendez-vous.

- L'absence de rendez-vous ou des rendez-vous obtenus depuis peu de temps (marqueur 1) ;
- Une proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi-urgent (marqueur 2) ;
- Une proportion élevée de patients qui ne sont pas inscrits auprès du médecin (marqueur 3) ;
- Une proportion significative de problèmes nécessitant une intervention chirurgicale ou radiologique, si le milieu offre de tels traitements (marqueur 4) ;
- Une faible proportion d'interventions préventives ou de suivi longitudinal des pathologies chroniques des patients (marqueur 5).

Particularités pour les marqueurs 1 et 2

L'absence de rendez-vous ou la présence de rendez-vous obtenus depuis peu de temps (marqueur 1) à eux seuls ne suffisent pas pour conclure qu'il s'agit d'une plage de services sans rendez-vous. Le marqueur 1 doit ainsi être combiné aux marqueurs 3, 4 ou 5, ou à l'un d'eux, pour conclure qu'il s'agit de services sans rendez-vous. Il n'est pas nécessaire que l'ensemble des trois marqueurs (3, 4 ou 5) soit présent.

De même, le marqueur 2 n'est pas déterminant à lui seul. Lorsqu'il y a une proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi-urgent (marqueur 2), et qu'à l'exception du marqueur 1, aucun autre marqueur (3, 4 ou 5) n'est présent, vous ne pouvez pas conclure qu'il s'agit de services rendus en sans rendez-vous.

Lorsque les marqueurs 1 **et** 2 sont associés, l'absence de rendez-vous ou de rendez-vous obtenus depuis peu de temps et une proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi-urgent, il doit y avoir l'un, ou une combinaison, des autres marqueurs (3, 4 ou 5) pour conclure qu'il s'agit de services rendus en sans rendez-vous.

Par conséquent, tout service que vous rendez et qui ne répond pas à ces critères est considéré comme de l'accès adapté ou sur rendez-vous.

Tableau des combinaisons de marqueurs

Combinaisons de marqueurs		Plage de SRV ?
Marqueur 1 <u>ou</u> 2	Seul	NON
	Avec la présence d'au moins un de ces marqueurs ○ Marqueur 3, 4 ou 5	OUI
Marqueurs 1 <u>et</u> 2	Seuls	NON
	Avec la présence d'au moins un de ces marqueurs ○ Marqueur 3, 4 ou 5	OUI

Lorsqu'un **médecin qui a une pratique différente, et qui ne fait ni inscription ni prise en charge de patients**, peut avoir droit à la compensation pour des frais de cabinet. Celui-ci peut s'adresser au comité paritaire pour faire évaluer sa situation. Dans le cas où le comité paritaire juge la pratique du médecin essentielle, il informera la Régie du nom du médecin, de **son lieu de pratique particulière reconnue ainsi que de la raison donnant droit au paiement des frais de cabinet. Sans ça, un médecin n'ayant aucune inscription au lieu de dispensation ne peut se prévaloir des frais de cabinet.**

Par ailleurs, un médecin peut réclamer l'un ou l'autre des deux forfaits disponibles (19928 ou 19929) s'il atteint, dans une même journée, les nombres requis de patients inscrits en cabinet en jumelant les patients vus au cabinet et à domicile.

Par exemple, un médecin ayant dispensé, au cours de la même journée, des services à six patients (inscrits en cabinet à son nom ou au nom de médecins de son groupe) vus en cabinet et à six patients (inscrits en cabinet à son nom ou au nom de médecins de son groupe) vus à domicile peut se prévaloir du forfait 19929 de 64.20\$.

Un médecin qui dispense des services dans plus d'un cabinet ne peut cumuler le nombre de patients pour atteindre 6 ou 12 patients.

Rappel : un maximum de 64,20 \$ est payable par journée à un médecin.

Exemples :

1. Un médecin dispense des services, dans une journée, à 3 patients au cabinet A et à 3 patients au cabinet B. Aucun forfait ne peut être réclamé par ce professionnel.

2. Un médecin dispense des services, dans une journée, à 5 patients au cabinet A et à 7 patients au cabinet B. Il peut se prévaloir du forfait 19928 de 32,10 \$ pour les patients vus au cabinet B.
3. Un médecin dispense des services, dans une journée, à 6 patients au cabinet A et à 8 au cabinet B. Il peut se prévaloir de deux forfaits 19928 de 32,10 \$, un pour les patients vus au cabinet A et un pour les patients vus au cabinet B.

HORS GMF

Il n'y a aucune notion de rendez-vous ou SRV pour un cabinet hors GMF

Code d'acte	Nombre de patients	Élément de contexte
Aucun forfait	- de 6 patients inscrits et vus	N/A
19928	6 à 11 patients inscrits et vus	N/A
19929	12 patients et + inscrits et vus	N/A

GMF

En SRV

Code d'acte	Nombre de patients	Élément de contexte
Aucun forfait	- de 10 patients (inscrits ou non) vus	N/A
19928	10 à 19 patients (inscrits ou non) vus	#G160
19929	20 patients et + (inscrits ou non) vus	#G160

Sur rendez-vous

Code d'acte	Nombre de patients	Élément de contexte
Aucun forfait	- de 6 patients inscrits et vus	N/A
19928	6 à 11 patients inscrits et vus	N/A
19929	12 patients et + inscrits et vus	N/A

GMF-R (EP 54)

En SRV

Code d'acte	Nombre de patients	Élément de contexte
Aucun forfait	- de 10 patients (inscrits ou non) vus	N/A
19928	10 à 19 patients (inscrits ou non) vus	#AR
19929	20 patients et + (inscrits ou non) vus	#AR

Sur rendez-vous

Code d'acte	Nombre de patients	Élément de contexte
Aucun forfait	- de 6 patients inscrits et vus	N/A
19928	6 à 11 patients inscrits et vus	N/A
19929	12 patients et + inscrits et vus	N/A

Frais de cabinet DMÉ

Le médecin qui assure la prise en charge et le suivi de clientèle en première ligne **en cabinet hors GMF, en GMF ou en GMF-mixte**, peut maintenant bénéficier d'une compensation pour les frais de cabinet liés à l'utilisation d'un dossier médical électronique (DMÉ), s'il satisfait aux dispositions de l'article 17.00. Cette compensation se facture à l'acte.

Critères :

- Le médecin offre des services de prise en charge et de suivi de patients en première ligne ;
- **Il doit compter 150 patients ou plus inscrits le premier jour du mois précédant chaque trimestre** (selon l'année civile). Le nombre de patients inscrits comprend ceux de tous les lieux de pratique du médecin. Les patients qui ont fait l'objet d'un transfert en bloc en vertu des dispositions de la Lettre d'entente n° 304 sont considérés dans le minimum de 150 patients inscrits aux fins de la facturation des frais de cabinet pour l'utilisation d'un DMÉ dès la date du transfert. **Le médecin qui a un permis de pratique de moins de 1 an est autorisé, peu importe le nombre de patients inscrits.**
- Lorsqu'il exerce dans plus d'un cabinet, le médecin peut facturer la compensation dans un seul de ses lieux de pratique, à son choix. Toutefois, le médecin membre d'un GMF doit obligatoirement facturer dans ce lieu ;

- Dans l'exercice de ses activités cliniques, le médecin doit utiliser la version la plus récente d'un DMÉ certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux ;
- Le médecin doit être un intervenant habilité au Dossier Santé Québec (DSQ).

Il faut s'assurer de conserver les pièces justificatives de vos frais pendant 5 ans, aux fins de vérifications de la RAMQ. Ces codes se facturent une seule fois par trimestre.

Modalités spécifiques pour le médecin qui participe à l'offre de service du sans rendez-vous d'un GMF-R (désigné réseau) en cabinet :

Des modalités spécifiques s'appliquent au médecin qui participe à l'offre de service du sans rendez-vous d'un GMF désigné réseau en cabinet. Le médecin qui ne fait pas partie du GMF-R, mais qui participe à son offre de service, peut facturer uniquement la compensation pour les frais d'acquisition et d'opération d'une licence (code 19979) s'il répond aux exigences suivantes :

- La situation du médecin doit correspondre à l'un des cas suivants :
 - si, dans les autres lieux où il pratique, le médecin offre des services de prise en charge et de suivi de clientèle en première ligne et que le DMÉ implanté au sein du GMF-R n'est pas interopérable avec celui ou ceux utilisés dans ses autres lieux de pratique. De plus, le médecin doit compter 150 patients ou plus inscrits le premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application, sur la base de l'année civile, en tenant compte de tous ses lieux de pratique ;
 - si, dans les autres lieux où il pratique, le médecin n'offre pas principalement des services de prise en charge et de suivi de clientèle en première ligne et compte moins de 150 patients inscrits le premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application, sur la base de l'année civile, en tenant compte de tous ses lieux de pratique.
- Le médecin doit rendre des services au sans rendez-vous du GMF-R au moins 11 jours par trimestre. Pour qu'un jour de service soit retenu, il doit compter minimalement 4 heures de service. Pour le médecin rémunéré à l'acte, le calcul du nombre d'heures de service est basé sur le total du tarif des actes effectués divisé par le taux horaire en vigueur du mode de rémunération à tarif horaire.
- Il doit facturer les services rendus au sans rendez-vous du GMF-R avec son numéro d'établissement.
- Pour pouvoir demander une compensation pour les frais d'acquisition et d'opération d'une licence, le médecin doit avoir engagé des frais pour l'acquisition et l'opération de cette licence et elle doit être implantée dans le GMF-R où il rend des services au sans rendez-vous. La compensation de 459,90 \$ (taxes incluses) pour les frais d'acquisition et d'opération d'une licence est la seule que ce médecin peut facturer, par trimestre, pour ce GMF-R.

Si le médecin participe à l'offre de service du sans rendez-vous de plus d'un GMF-R, il peut demander la compensation des frais liés à l'utilisation d'un DMÉ dans un seul lieu.

Les majorations des annexes XII, XII-A et XX ne s'appliquent pas à la compensation des frais liés à l'utilisation d'un DMÉ.

Le médecin doit conserver ses pièces justificatives pendant 5 ans à compter de la date du paiement. Ces pièces pourraient être demandées par la Régie pour vérification.

Le tableau suivant présente les frais de cabinet liés à l'utilisation d'un DMÉ pouvant être compensés selon que le médecin pratique en GMF, hors GMF ou SRV d'un GMF-R, ainsi que les codes de facturation associés:

Frais de cabinet pour DMÉ	Code de facturation	Compensation par trimestre, taxes incluses	Médecin pratiquant en GMF	Médecin pratiquant hors GMF	Médecin pratiquant au SRV d'un GMF-R
Équipement et frais accessoires	19976	287,45\$		Oui	
Lien Internet et commutateur	19977	700,35\$		Oui (un seul médecin par cabinet)	
Licence	19978	459,90\$	Oui	Oui	
Licence (SRV – GMF-R)	19979	459,90\$			Oui

Trimestre :

1. Janvier à mars
2. Avril à juin
3. Juillet à septembre
4. Octobre à décembre



Plan Élite – utiliser le type **FORFAIT** – ajouter l'élément de contexte **#AR** pour le code **19979**

Pratique en GMF (EP33)

Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération applicables, en phase transitoire, au médecin qui exerce sa profession dans le cadre d'un GMF. En plus des visites et actes, le médecin exerçant en GMF peut se prévaloir des forfaits suivants :

FORFAIT POUR LE TRANSFERT TEMPORAIRE DE RESPONSABILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE ET DU SUIVI DE GROSSESSE

Le forfait s'applique au médecin qui, dans le cadre de sa pratique en obstétrique, assume temporairement le suivi d'une patiente inscrite auprès d'un autre médecin du même GMF. Le médecin **doit détenir des privilèges en obstétrique**. Payable une fois par grossesse lors de l'examen de prise en charge de grossesse.

19074

Forfait pour le transfert temporaire de responsabilité de la prise en charge et le suivi de grossesse (se facture en plus du code 15189 – supplément de transfert temporaire de grossesse)

FORFAIT DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI - raccourci GMF

Le forfait de prise en charge et de suivi du patient inscrit en GMF est facturé une fois par année civile (1er janvier au 31 décembre) par GMF et par patient, lors de la première visite annuelle du patient au GMF. Le forfait s'ajoute à la rémunération du médecin pour chacun de ses patients inscrits.

8875 Forfait de prise en charge et de suivi



Plan Élite – Pour les médecins qui utilisent la castonguette électronique intégrée avec un DMÉ, **l'ajout se fait automatiquement** selon les règles établies pour le forfait GMF (8875).

RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN RESPONSABLE EN GMF

Les activités du médecin responsable d'un GMF, ou de celui qui l'assiste, sont, de façon exclusive, rémunérées selon une formule à l'acte prévoyant le paiement de forfaits alloués, sur une base annuelle.

9750 Rémunération du médecin responsable en GMF
Inscrire le nombre de forfaits hebdomadaires



Plan Élite – veuillez utiliser le type **FORFAIT**

INSCRIPTION EN GMF

Pour avoir droit au forfait d'inscription générale de la clientèle, l'inscription d'un patient se fait à l'occasion d'un examen, d'une intervention clinique ou d'une psychothérapie à l'aide du formulaire Inscription auprès d'un médecin de famille. Lors de l'inscription, le médecin indique la date de début de l'inscription, soit la date de la visite, le lieu où le suivi sera effectué, le code de vulnérabilité, s'il y a lieu, et toutes les données requises. **Il doit conserver au dossier l'original du formulaire signé par son patient et lui en remettre une copie. Nous vous rappelons que vous ne devez pas transmettre le formulaire à la Régie.**

L'inscription doit être reçue à la Régie dans les 90 jours suivant l'examen, l'intervention clinique, la psychothérapie donnant droit à l'inscription, à défaut de quoi elle sera refusée.

Cliniques-réseaux

GMF-AR (EP54)

Clinique médicale, site d'un GMF, qui dispense des services de première ligne auprès de toute clientèle inscrite ou non, après avoir conclu une entente avec un établissement dont relève la mission réseau, soit un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou un établissement non fusionné.

Élément de contexte à indiquer	SRV (lieu physique unique) : Sans rendez-vous – GMF désigné accès-réseau (GMF-AR) ou alias #AR Sur les demandes de patients et frais de cabinet
Supplément de garde	Lundi au vendredi (sauf jour férié) de 18 h à 22 h : 19893 Samedi, le dimanche ou un jour férié, de 8 h à 22 h : 19894 Facturable en plus de la rémunération prévue pour les services rendus durant la garde en horaire défavorable. Veuillez inscrire le nombre de minutes ainsi que l'heure de début et de fin de la garde. Ex : 19893:120:2000-2200
Activités médico-administratives	Pour l'organisation des services de première ligne, la coordination avec l'établissement et les autres intervenants du réseau local de santé et de services sociaux (RLS), la confection des horaires de garde et le recrutement. 3 forfaits (19895) sont alloués par semaine , dont 2 des 3 forfaits doivent être facturés par le médecin responsable du GMF-R. Pour le forfait résiduel, le médecin doit appliquer l'élément de contexte « alias #FR – forfait résiduel pour les activités médico-administratives en GMF-R ». Lorsque le médecin effectue des activités médico-administratives en GMF-R, il ne doit facturer aucun service au cours de cette période . De plus, le temps consacré aux activités médico-administratives doit être déduit du forfait horaire (mode de rémunération mixte) ou des heures rémunérées à tarif horaire ou à honoraires fixes. Veuillez inscrire l'heure de début et de fin de l'activité. Ex : 19895:0800-0900,19895:1400-1500,19895:1800-1900

Inscription de la clientèle

FORFAIT INSCRIPTION GÉNÉRALE

Le forfait d'inscription générale est versé automatiquement par la Régie au médecin de famille pour tous ses patients actifs au 1er janvier de l'année de versement. Le patient est considéré actif lorsqu'il a rencontré **son médecin de famille ou, dans le cas d'une UMF, un médecin du groupe, au cours des 36 mois précédents**. Le forfait est versé dans sa totalité même si l'inscription ou la modification a eu lieu en cours d'année d'application.

Si un patient fait l'objet d'une inscription auprès de deux médecins de famille, le calcul se fait alors sur la base des mois entiers et le mois de la deuxième inscription est comptabilisé en faveur du premier médecin.

Ce versement forfaitaire sera effectué au mois de mai de chaque année. Montant maximum de 11,35 \$, calcul au prorata si plus d'un médecin.

LA GRANDE INSCRIPTION – LETTRE D'ENTENTE 321

Modalité particulière concernant la prise en charge en lot de patients attribués en lot par le guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF). Veuillez consulter les infolettres en cliquant sur les liens suivants :

[Infolettre 303](#) et [Infolettre 100](#).

LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE

L'inscription de patient comme clientèle vulnérable permet de facturer un forfait de responsabilité à chaque examen, intervention clinique ou psychothérapie d'un patient et de recevoir un forfait annuel pour la prise en charge du patient inscrit. Les patients doivent présenter une ou plusieurs conditions de vulnérabilité numérotées de 01 à 19 (maximum trois codes de vulnérabilité que vous pouvez inscrire à la RAMQ).

L'identification des patients doit être transmise à la RAMQ conformément aux modalités prévues selon : remplir et conserver une copie du formulaire n° 4096 ou faire l'inscription du patient à la RAMQ par le biais des Services en ligne.

TABLEAU DES CONDITIONS DE VULNÉRABILITÉ

Code de catégorie de problème de santé	Catégories de problèmes de santé ou d'âge correspondant à la condition de vulnérabilité	Lettre associée
01	Problèmes de santé mentale chroniques et récidivants (DSM-V) : troubles d'anxiété généralisée, troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie).	A
02	Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à sévère (selon critères cliniques ou selon les médicaments requis pour contrôler l'asthme), pneumopathies professionnelles.	B
03	Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, hypertension sévère (grade 3).	C
04	Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou en phase palliative.	D
05	Diabète avec hémoglobine A1C à 6,5 ou plus au moment du diagnostic excluant le diabète de grossesse.	E
06	Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de drogues dures ou d'alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous traitement à la méthadone ou de buprénorphine.	F
07	VIH/SIDA, hépatite C.	G
08	Maladies dégénératives du système nerveux, démence avec MMSE de 26 et moins, blessés médullaires avec séquelles permanentes entraînant une invalidité et des traumatismes crâniens avec séquelles permanentes entraînant une invalidité.	H
09	Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite, rhumatoïde, psoriasis avec atteinte autre que cutanée, lupus, sclérodermie et autres collagénoses, colite ulcéreuse, maladie de Crohn.	I
10	Troubles dépressifs majeurs aigus, premier épisode ou troubles anxieux aigus, premier épisode. Renouvelable tous les 24 mois.	A
11	Troubles dépressifs majeurs récidivants.	A

12	Insuffisance rénale chronique avec une clairance de la créatine, inférieure à 30 ml par minute, insuffisance hépatique.	J
13	Maladies thrombogènes nécessitant une anticoagulation à vie, fibrillation auriculaire avec CHADS à 2 et plus.	K
14	Fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulothérapie à vie et suivie par RIN. Date de fin : 30 juin 2019	L
15	Trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité pour les patients âgés de moins de 18 ans.	M
16	Déficiência intellectuelle pour les patients présentant des troubles importants d'expression et de compréhension.	N
17	Déficiência auditive lorsque la communication avec le patient se fait de façon gestuelle ou par écrit et déficiência visuelle nécessitant la présence d'un accompagnateur lors de la rencontre du patient avec le médecin.	O
18	Douleur chronique qui persiste depuis plus de six (6) mois liée à une condition chronique et provoquant une incapacité fonctionnelle ou nécessitant la prise continue d'une médication sur ordonnance lui permettant d'être fonctionnel.	P
19	Accident vasculaire cérébral entraînant des troubles graves de mobilité, de comportement, d'expression ou de compréhension.	Q
20	Problèmes de santé (DSM-IV) : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles envahissants du développement (troubles du spectre de l'autisme, Asperger), trouble de panique.	A

FORFAIT ANNUEL DE PRISE EN CHARGE POUR UN PATIENT VULNÉRABLE

Groupe de vulnérabilité		Cabinet/ Domicile
GROUPE I	Le patient est identifié à une seule catégorie de problèmes de santé	62,50 \$
GROUPE II	Le patient est identifié à deux catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle).	93,75 \$
GROUPE III	Le patient est identifié à trois catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle).	125,00 \$
GROUPE IV	Le patient est identifié à deux catégories ou plus de problèmes de santé, dont une de ces catégories est la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle).	125,00 \$

Forfait annuel de prise en charge : l'entente prévoit le versement d'un forfait annuel de prise en charge des patients vulnérables inscrits, selon le groupe.

Payé 4 fois par année : le montant est versé sur une base trimestrielle, le premier trimestre débutant le 1^{er} janvier de chaque année.

Date de début = première visite du patient : le forfait est payé à partir de la date de l'inscription du patient et le montant se calcule proportionnellement au nombre de mois de l'année d'application qui reste à écouler.

Identification de vulnérabilité : en tout temps, une catégorie de problème de santé peut être identifiée pour un patient en avisant la Régie au plus tard 90 jours suivant l'examen au cours duquel le problème est identifié ou modifié. S'il y a lieu, le niveau du forfait est rajusté le mois suivant la modification apportée par le médecin.

Patient actif au 1^{er} janvier : le forfait annuel est payable pour chaque patient considéré comme vulnérable actif au 1^{er} janvier de l'année du versement du forfait annuel. Est considéré comme vulnérable actif le patient qui a rencontré son médecin de famille auprès duquel il est inscrit, ou, dans le cas d'une UMF, un médecin du groupe, au cours des 12 mois précédents. Si cette condition n'est pas remplie, le forfait sera payé à partir du prochain examen, intervention clinique, psychothérapie ainsi que le forfait de responsabilité facturé pour ce patient, proportionnellement au nombre de mois de l'année d'application qui reste à écouler, incluant le mois de l'examen, de l'intervention clinique, de la psychothérapie ainsi que le forfait de responsabilité.

Changement de médecin : lorsqu'un patient déjà inscrit s'inscrit auprès d'un autre médecin, le forfait annuel payé à chacun des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts pour chacune des inscriptions. Le calcul se fait sur la base de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier médecin.

RÉTABLISSEMENT D'UNE INSCRIPTION

Dans le cas où un médecin est d'avis que l'inscription auprès d'un autre médecin d'un de ses patients inscrits ne reflète pas une prise en charge effective par cet autre médecin, il peut communiquer avec ce patient et lui demander, au moyen du formulaire apparaissant à l'annexe II de la présente entente, de rétablir sa première inscription. Pour que la Régie puisse procéder au rétablissement de l'inscription, ce formulaire doit être acheminé à la Régie **au plus tard dans les six (6) mois suivant la date du rapport transmis par la Régie** pour informer le médecin de la fin de l'inscription de son patient.

Le second médecin ne peut plus contester le rétablissement de l'inscription d'un patient auprès de son premier médecin de famille.

AVIS : Voir le formulaire [Rétablissement d'une inscription auprès d'un médecin de famille](#) (4055).

CONSERVATION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUPRÈS D'UN MÉDECIN DE FAMILLE

La Régie peut demander au médecin de fournir une copie du formulaire d'inscription signé par le patient et lui-même. Le formulaire doit être conservé par le médecin dans le dossier médical du patient.

RETRAITE D'UN MÉDECIN DE FAMILLE

Le médecin de famille qui prend sa retraite ou diminue sa pratique en vue de sa retraite doit informer la Régie afin qu'elle puisse mettre fin aux inscriptions ou à une partie des inscriptions des patients qu'il ne suivra plus.

Le médecin qui omet d'informer la Régie demeure assujetti aux obligations de prise en charge et de suivi de sa clientèle. **De ce fait, ces patients ne peuvent pas faire l'objet de référence par le guichet d'accès du CSSS en tant que patients sans médecin de famille.**

Sur demande du médecin de famille lui-même auprès de la RAMQ et/ou de son coordonnateur de guichet, sa clientèle devient admissible aux fins du versement du supplément prévu dans les cas suivants :

- Le médecin de famille prend totalement sa retraite à une date connue, celle-ci au plus tard 24 mois suivant sa demande ;
- Le médecin de famille est en invalidité partielle pour une période suffisamment importante ;
- Le médecin de famille réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu'en première ligne.

Tant qu'il n'est pas inscrit auprès d'un autre médecin de famille, le patient demeure inscrit auprès de son médecin de famille.

Médecin enseignant

RÉSIDENT / EXTERNE

En sus de toute autre rémunération prévue, est applicable au médecin qui, selon l'assignation du responsable de stages, assume la prise en charge et la responsabilité de l'externe et/ou du résident **au cours d'une plage horaire**. Cette prise en charge et cette responsabilité impliquent principalement des activités de supervision clinique.

Les activités visées par les présentes sont rémunérées sous forme d'un demi-perdiem par plage horaire d'activités. Chaque demi-per diem doit viser des activités dont la durée totale minimale est de 3,5 heures la même journée. Lorsque plus d'un médecin assure la prise en charge et la responsabilité d'un externe ou d'un résident durant la même demi-journée, la durée de l'activité s'évalue en tenant compte du rôle de l'ensemble des médecins, sans dépasser la durée de l'activité de l'externe ou du résident. Les médecins doivent alors convenir de qui parmi eux va réclamer le demi-per diem pour cette demi-journée.

Au cours d'une demi-journée, un seul médecin peut être rémunéré pour la responsabilité assumée en regard d'un résident ou d'un externe.

Code de supervision

19910	Tableau de la liste 1 pour un résident	5XXXXXX (5 + 5 chiffres)
19913	Tableau de la liste 1 pour un externe	XXXXXXXXXX (E + 8 chiffres) <i>Inscrire E en majuscule</i>
19916	Tableau de la liste 2 pour un résident	5XXXXXX (5 + 5 chiffres)
19919	Tableau de la liste 2 pour un externe	XXXXXXXXXX (E + 8 chiffres) <i>Inscrire E en majuscule</i>

Veillez indiquer le numéro du résident ou de l'externe sur votre demande de paiement ainsi que l'heure de début du bloc de supervision de 3.5 heures.



Plan Élite – il est important de remplacer la lettre R par 5 à la saisie, sinon le système refusera la demande.

Le médecin peut, pendant une demi-journée, assumer la responsabilité de plus d'un résident et/ou externe. Le médecin facture, quotidiennement, par lieu de stage, le nombre de demi-per diem pour le (ou les) résident(s) ou externe(s) supervisé(s).

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) - LETTRE D'ENTENTE 213

Le médecin qui assure la **supervision du stage d'une IPS** pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un externe de la section I de l'Entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin enseignant.

Avant de facturer le forfait de formation, vous devez identifier si le lieu de formation est lié aux listes 1 ou 2. **Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.**

19922	Liste 1
-------	---------

19925	Liste 2
-------	---------

Veuillez indiquer le numéro de l'IPS-SPL sur votre demande de paiement.

INTÉGRATION IPS-SPL ET CIPS-SPL – LETTRE D'ENTENTE 389

Les activités du médecin partenaire reliées à la surveillance générale des activités médicales de l'IPS-SPL ou à la supervision de la CIPS-SPL ainsi que de l'observance des normes poursuivant ces finalités reliées à l'exercice des activités médicales de l'IPS-SPL ou de la CIPS-SPL, incluant les discussions de cas, les rencontres d'équipes, la révision de dossiers, sont rémunérées à l'acte selon un ou plusieurs forfaits mensuels.

42271	Cabinet privé
-------	---------------

PATIENT INSCRIT PAR UNE IPSPL/CIPSPL

Patient non vulnérable : L'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) ou la candidate (CIPSPL) peut procéder, avec le consentement du médecin partenaire, à l'inscription du patient **non vulnérable** lors de la visite ou de la consultation.

Lors de visites ou de consultations effectuées par l'IPSPL/CIPSPL **sans le médecin**, il peut facturer uniquement le **supplément annuel 8875** s'il fait partie d'un GMF.

Si le médecin participe aux services, il peut facturer la visite et les suppléments applicables.

Si la prise en charge du patient a été faite **sans le médecin** par l'IPSPL/CIPSPL, il pourra facturer la visite de prise en charge et les suppléments applicables à un rendez-vous ou en accès adapté la première fois qu'il verra ce patient, et ce, même s'il a été inscrit antérieurement par l'IPSPL.

Si aucune facture n’a été faite pour un patient, le médecin doit remplir son registre de consultations pour maintenir **l’inscription active**.

Patient vulnérable : La prise en charge d’un patient vulnérable peut se faire par une IPSPL/CIPSPL. Cependant, les conditions de vulnérabilité ne pourront être ajoutées à l’inscription qu’à l’occasion d’une visite avec le médecin, par le médecin.

Si aucune facture n’a été faite pour un patient vulnérable, le médecin doit **revoir le patient annuellement** pour maintenir l’inscription active.

COLLABORATION AVEC UNE CLINIQUE D’IPS

Accord 806

Les activités du médecin partenaire reliées à la surveillance générale des activités médicales de l’IPS-SPL ou à la supervision de la CIPS-SPL dans une clinique d’IPS ainsi que de l’observance des normes poursuivant ces finalités reliées à l’exercice des activités médicales de l’IPS-SPL ou de la CIPS-SPL, incluant les discussions de cas, les rencontres d’équipes, la révision de dossiers, sont rémunérées à l’acte selon un ou plusieurs forfaits mensuels.

42271	Cabinet privé
-------	---------------

CNESST

Il est essentiel d'inscrire la date de l'accident. Vous n'avez pas à joindre une copie du formulaire de CNESST à la demande de paiement.

Pour plus de détails sur les codes de CNESST, veuillez vous référer au manuel de facturation.

Code	Description
1. Attestation médicale (PAPIER VERT)	
9926	Rédaction et remise sans délai au travailleur du formulaire d'attestation médicale prescrit par la Commission. Ce formulaire n'est facturable qu'une seule fois par événement.
2. Rapport sommaire de prise en charge (PAPIER BRUN)	
9927	Rédaction et expédition à la Commission, dans les six (6) jours du premier examen, du formulaire de prise en charge prescrit par la Commission : il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin si la date prévisible de consolidation est de plus de quatorze (14) jours complets après la date où le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.
3. Rapport d'évolution (PAPIER BRUN)	
9928	Rédaction et expédition immédiate à la Commission du formulaire d'évolution prescrit par la Commission.
4. Rapport final (PAPIER BLEU)	
9930	Rédaction et expédition à la Commission, dès que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée, du formulaire de rapport final prescrit par la Commission. Ce formulaire n'est facturable qu'une seule fois par événement.
5. Information complémentaire écrite	
9929	Rédaction et expédition à la Commission, dans les dix (10) jours de la réception de la demande, du formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission.

6. Bilan médical	
9907	Pour l'information verbale fournie
9914	Considération spéciale en raison de la complexité
9915	Considération spéciale en raison de la complexité
9916	Considération spéciale en raison de la complexité
7. Maintien du lien d'emploi	
9908	Pour l'opinion professionnelle obtenue du médecin
8. Rapport complémentaire	
9909	Rédaction et expédition à la Commission, dans les trente (30) jours de la réception de la demande, du formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission.
9. Rapport de consultation motivée	
9910	Rédaction du rapport de consultation motivé et expédition au médecin qui a la charge du travailleur.
10. Rapport d'évaluation médicale	
9944	Rédaction du rapport de consultation motivé et expédition au médecin qui a la charge du travailleur.
9901	Supplément en neurologie et neurochirurgie, dans le cas de pathologies cérébrales organiques, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les parties à l'entente.
9978	Examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit.
9946	Examen du travailleur dans un délai de un à cinq jours consécutifs suivant la demande de la Commission, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit.
9947	Considération spéciale en raison de la complexité
9948	Considération spéciale en raison de la complexité
9949	Considération spéciale en raison de la complexité

11. Bureau d'évaluation médicale

9938	Avis écrit donné au vu du dossier
9939	Avis écrit donné après examen du travailleur
9977	Supplément lorsque effectué en cabinet. Ce supplément ne s'applique pas lorsque l'examen est effectué dans les bureaux du Bureau d'évaluation médicale (BEM). Pour être payable, l'examen doit avoir été fait au cabinet privé du médecin.
9936	Dossier complexe – Médecin qui participe à la préparation de l'avis commun
9937	Dossier complexe – Honoraires additionnels pour le médecin qui rédige l'avis commun
9981	Considération en raison de la complexité
9982	Considération en raison de la complexité

12. Indemnité

Compensation équivalente à 40% des honoraires prévus pour l'examen ou l'évaluation médicale à titre de médecin désigné d'un travailleur qui ne se présente pas au rendez-vous. Ne s'applique pas si le temps prévu est comblé par l'examen d'un autre travailleur. (#AGOS)

13. Audiologie

9919	Supplément pour la production des tests audiologiques
------	---

14. Certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite

9970	Rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. <i>Inscrire comme date d'accident la date à laquelle le formulaire recommandant le retrait préventif est complété. S'il y a lieu, inscrire un diagnostic de grossesse.</i>
------	--

15. Assignment temporaire d'un travail

9971	Rédaction, remise de la copie au travailleur et expédition sans délai du formulaire d'assignment temporaire prévu par la Commission ou identique à celui-ci.
------	--

16. Étude de dossier particulier	
9942	Étude de dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission d'un rapport, pour chaque médecin.
9911	Considération en raison de la complexité
9912	Considération en raison de la complexité
9913	Considération en raison de la complexité
17. Certificat médical du plongeur professionnel	
9954	Rédaction et remise sans délai au travailleur du certificat médical du plongeur professionnel.

IVAC

Code	Description
1. Attestation médicale IVAC-CIVISME (initial)	
15795	Le diagnostic, le siège de la blessure, les autres diagnostics actuels physiques ou psychiques pouvant avoir des répercussions, de même que les antécédents pertinents ; s'il y a lieu, arrêt de travail ou d'études et soit la date prévisible de consolidation, soit la période prévisible de consolidation de la blessure d'une personne victime ou d'un sauveteur ; cette attestation est remise par le médecin qui la complète à cette victime ou sauveteur.
2. Rapport médical IVAC-CIVISME (évolution)	
15796	Comporte : 1. La date de l'acte criminel ou du sauvetage 2. Le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents 3. La période prévisible de consolidation de la blessure 4. L'évolution de la blessure et l'évaluation des séquelles à prévoir
3. Rapport médical IVAC-CIVISME (final)	
15797	Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin, lorsque la blessure de la victime ou du sauveteur est consolidée ; ce rapport comporte notamment les diagnostics finaux et renseignements complémentaires pertinents et il décrit les limitations fonctionnelles qui résultent de la blessure.

Codes de médicaments et patients d'exception

Conditions spécifiques :

- Nous vous invitons fortement à inscrire toutes vos demandes via le registre prévu à cet effet, patients et médicaments d'exception, dans vos services en ligne de la RAMQ.
Il est prévu qu'éventuellement, les forfaits ne seront facturables que si les demandes ont été transmises par ce service en ligne.
- Les forfaits ne sont pas facturables en rémunération mixte.

Code	Libellé	Tarif
70017	Demande d'autorisation ou de renouvellement de médicament d'exception transmise à la Régie.	36\$
70018	Demande d'autorisation de patient d'exception transmise à la Régie.	80\$
70019	Demande d'autorisation ou de renouvellement de médicament d'exception transmise à un assureur privé ou à un régime fédéral.	36\$
70020	Demande d'autorisation de patient d'exception transmise à un assureur privé ou à un régime fédéral.	80\$

GAP – lettre d’entente 393

GÉNÉRALITÉS DE LA NOUVELLE ENTENTE – 1^{er} JUIN 2024

Offre médicale

- **Les engagements** : Sur une base volontaire, dans leur clinique respective, les MD forment un groupe afin d’inscrire collectivement un nombre de patients en attente du GAMF. Cela est effectif depuis le 1^{er} juin 2022. En tant que groupe, les MD s’engagent à offrir un certain nombre de plages de rendez-vous chaque année pour les patients inscrits collectivement. Ces plages sont réparties sur l’année afin de garantir un accès continu aux soins, aussi bien pour les besoins urgents que pour les suivis réguliers.

Les groupes déjà formés continuent d’exister et les engagements pris selon l’ancienne entente (avant le 1^{er} juin 2024, soit la lettre d’entente 368) sont reconduits.

- **Répartition trimestrielle** : Chaque trimestre, les MD doivent offrir un nombre minimum de rendez-vous.
 - Du 1^{er} juin au 31 août 2024 : 0,20 plage par patient.
 - Du 1^{er} septembre au 30 novembre 2024 : 0,25 plage par patient.
 - Du 1^{er} décembre 2024 au 28 février 2025 : 0,30 plage par patient.
 - Du 1^{er} mars au 31 mai 2025 : 0,25 plage par patient.
 - **Cas exceptionnel** : Pour le trimestre de juin à août 2024, une offre réduite de 0,15 plage est acceptée pour faciliter la relance des services.

Médecin responsable

- **Qui est responsable ?** Un des médecins du groupe devra être désigné comme médecin responsable. Ce rôle implique de s’assurer que le groupe respecte les engagements (nombre de plages offertes) et de répartir les forfaits entre les médecins du groupe.
- **Pas de rémunération supplémentaire** : Le rôle de médecin responsable n’est pas rémunéré, mais il est essentiel pour le bon fonctionnement du groupe.

MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Les visites suivantes pourront être facturées pour un patient inscrit collectivement (autant en présentiel qu'en téléconsultation) :

- Visite de suivi vulnérable (lorsque vous jugez que le patient a une condition qui le rendrait éligible à avoir un code de vulnérabilité)
- Visite de suivi non vulnérable
- Intervention clinique

Contexte de facturation : lors de la facturation, il faudra indiquer l'élément de contexte "Patient inscrit en groupe". Il est toujours de la responsabilité du médecin d'identifier les patients inscrits collectivement.



Plan Élite – utiliser le contexte **#GAP** sur chaque visite de suivi ou sur l'intervention clinique.

Visites sans inscription collective dans la clinique du MD :

- Si le MD voit un patient lors d'une plage GAP sans qu'il soit inscrit collectivement à sa clinique, il faut facturer la visite selon les modalités habituelles des consultations sans rendez-vous (VPC, VPM ou IC) avec l'élément de contexte "Visite effectuée pendant une plage réservée au GAP" à partir du 23 septembre 2024.

Forfait pour plage utilisée (code 42267) :

- Un forfait de **50 \$** est disponible pour chaque **plage utilisée**, que ce soit par un patient inscrit collectivement ou un patient référé par le GAP.
- Ce forfait est limité au nombre de plages offertes par le groupe. Si 250 plages sont offertes, mais que seulement 215 sont utilisées, le MD ne pourra facturer que 215 forfaits, soit 10 750 \$ (215 x 50 \$), mais le groupe ne pourra jamais facturer plus de 250 unités de ce forfait (le nombre de plages offertes).
- Le forfait doit être facturé à la dernière date du trimestre d'application.

Forfait par patient inscrit collectivement (code 42251) :

- En tant que groupe, le MD peut bénéficier d'un **forfait trimestriel de 12,50 \$** par patient inscrit collectivement prévu à l'engagement (code de facturation **42251**). Ce montant est disponible si le groupe respecte les engagements de services médicaux (une plage par patient inscrit collectivement par an).
- Si le MD offre entre **90 %** et **100 %** des plages prévues, il recevra alors une partie du forfait au prorata.
- Le forfait doit être facturé à la dernière date du trimestre d'application.

Exemple

Contexte : Au trimestre du 1^{er} septembre au 30 novembre, vous avez 1000 patients prévus à l'engagement et l'offre médicale doit être de 0.25 plage par patient, soit 250 plages offertes.

Vous atteignez la cible à 100% (au moins 250 plages offertes).

Le médecin responsable répartit 1 000 forfaits entre les médecins du groupe selon leur participation :
 $12.50\$/\text{patient} \times 1\,000 = 12\,500\$$

Vous n'atteignez pas la cible, mais vous avez offert au moins 90% des plages (minimum 225, mais moins de 250 plages offertes).

Le médecin responsable répartit au prorata les forfaits entre les médecins du groupe. Si vous offrez 225 plages, cela constitue 90% de l'engagement, soit 900 forfaits : $12.50\$/\text{patient} \times 900 = 11\,250\$$

Vous n'atteignez pas la cible de 90% (moins de 225 plages offertes).

Le groupe ne peut pas facturer les forfaits à moins d'avoir été autorisé par le comité paritaire à les facturer au prorata.

Comment facturer les forfaits ?

- Pour facturer les forfaits **42251** et **42267**, il est essentiel que le MD contacte la personne responsable du groupe qui lui dira combien d'unités il a le droit de facturer pour chacun de ces forfaits.

Refus possibles :

- Si le groupe n'atteint pas les cibles (moins de 90 % des plages offertes), les forfaits pourront être réduits ou refusés. Il est aussi très important pour les médecins responsables de s'assurer d'avoir les bons chiffres lors de la répartition des unités des forfaits, pour éviter les refus lorsque trop de forfaits sont facturés pour un groupe.

AUTRES MODALITÉS

Transfert de patients : Si un médecin quitte le groupe (retraite, déménagement, etc.), ses patients peuvent être transférés à un autre médecin du groupe ou à l'ensemble du groupe, selon les besoins.

Frais de cabinet : Il est possible de demander une compensation pour les frais de cabinet (codes **19928** pour 10 patients vus et **19929** pour 20 patients vus sans rendez-vous).

EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE

Que se passe-t-il en cas de congé prolongé ? Si le MD est en congé (maternité, maladie, etc.), le groupe de médecins doit respecter les engagements (nombre de plages offertes) pour que le MD puisse toucher les forfaits prévus, même s'il n'est pas physiquement présent. Si le groupe atteint ses objectifs, il est considéré comme les ayant atteints également.

Le MD doit indiquer comme **date de service le dernier jour du trimestre d'application**. Toutefois, s'il devient inadmissible ou en congé prolongé en cours de trimestre, il doit facturer ce forfait la veille de l'inadmissibilité ou du congé en utilisant l'élément de contexte **Inadmissible à la facturation des forfaits codifiés 42251 ou 42267 à la dernière journée du trimestre en cours**.



Plan Élite – utiliser le contexte #INAD

Formation continue (Annexe XIX)

Le formulaire 3814 est accessible seulement par les SERVICES EN LIGNE de la RAMQ.

GÉNÉRALITÉS

Au moment de transmettre ce formulaire, **vous n'avez pas à faire parvenir à la Régie l'attestation de présence** à une formation dûment signée par le responsable officiel d'une session de formation continue. **Vous devez cependant la conserver pendant cinq ans.** La Régie peut vous la demander en tout temps.

Vous devez réclamer cette allocation forfaitaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la formation reçue.

Vous avez droit à sept (7) journées de formation par période de douze (12) mois de pratique active (année civile). Ces journées ne peuvent être utilisées au cours de l'année ou des années subséquentes.

Si vous êtes à honoraires fixes, vous pouvez réclamer 10 jours par année. Vous pouvez reporter à l'année suivante et pour cette seule année le nombre de jours de perfectionnement (ne doit pas dépasser dix (10) jours).

Deux (2) sessions de formation continue dispensées à l'extérieur du Québec sont admissibles une fois par année. Dans ce cas, les cours de formation continue doivent avoir été validés, au préalable, quant à leur durée et à leur mérite scientifique, par le Comité paritaire. Ces démarches doivent être faites un (1) mois avant le départ, pour obtenir le numéro d'autorisation.

Tout médecin qui bénéficie des mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente (médecins ayant une pratique en région éloignée).

Voici le lien de la page de la FMOQ où vous retrouverez le formulaire à compléter, le numéro de téléphone et la démarche à suivre. C'est dans la 2^e section de la page web :

<https://www.fmoq.org/formation/politiques/allocations-et-ressourcement/>

Ne sont pas considérées comme dispensées à l'extérieur du Québec les sessions de formation qui se tiennent à Ottawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.

Si vous participez à une activité de formation de groupe dans le cadre de la méthode de l'**accès adapté**, vous devez facturer à l'acte avec le code 19739, et si vous êtes médecin formateur, le code **19740**.

PROCÉDURE AFIN DE REMPLIR LE FORMULAIRE 3814

PROFESSIONNEL

NOM	PRÉNOM	N° DU PROFESSIONNEL
-----	--------	---------------------

Nom : nom de famille;

Prénom : prénom usuel;

Numéro du professionnel : numéro d'inscription à la Régie (7 chiffres).

FORMATION CONTINUE

JOUR	01	02	03	04	05	06	07	PÉRIODE DU		
QUANTIÈME								ANNÉE	MOIS	JOUR
DURÉE (1 jour ou 0,5 jour)								AU		
								ANNÉE	MOIS	JOUR
ALLOCATION FORFAITAIRE (montant demandé par jour)								MONTANT TOTAL DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE		

Quantième : date représentée par un nombre à deux chiffres de 01 à 31 ;

Période : dates du début et de la fin de la période couverte par le séjour (AAAAMMJJ) ;

Durée : valeur du jour facturée ; 0,5 pour une demi-journée (minimum 3 heures ou 3 crédits) ou 1 pour une journée (minimum 6 heures ou 6 crédits) ;

Allocation forfaitaire : montant réclamé pour une demi-journée (354,50 \$) ou pour une journée (709 \$) ;

Montant total pour l'allocation forfaitaire : inscrire la somme des montants réclamés.

LIEU DE LA FORMATION <i>Si la formation a eu lieu à Ottawa (Ont.), Campbellton (N.-B.) ou à Terre-Neuve-et-Labrador, veuillez cocher Québec.</i>		
☐ QUÉBEC	NOM DE L'ORGANISME	
☐ HORS DU QUÉBEC	LIEU DE LA FORMATION (ville et province canadienne ou pays étranger)	NUMÉRO D'AUTORISATION ACCORDÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION
L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue : ☐ OUI ☐ NON		
Mode de formation : ☐ Webdiffusion ☐ En salle		

Note : Les formations reçues à Ottawa (Ont.), Campbellton (N.-B.) et dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador sont considérées comme étant suivies au Québec.

Québec : case à cocher lorsque la formation s'est donnée au Québec ;

Nom de l'organisme : si la case « Québec » est cochée, choisir le nom de l'organisme agréé. Assurez-vous de la conformité du nom de l'organisme auprès de votre formateur ;

Hors du Québec : case à cocher lorsque la formation s'est tenue à l'extérieur du Québec ;

Lieu de la formation (ville, province ou autre) : si la case « Hors du Québec » est cochée, vous devez inscrire l'endroit où la formation s'est donnée. Inscrire le nom de la ville ainsi que la province, l'état ou autre ;

Numéro d'autorisation accordée par le conseil consultatif FMOQ-MSSS : si la case « Hors du Québec » est cochée, inscrire le numéro d'autorisation qui paraît sur votre document d'autorisation ;

L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue : cochez la case « oui » si l'attestation de présence est signée, ou cochez la case « non ».

Mode de formation : case à cocher afin de déterminer si la formation est suivie par webdiffusion ou en salle.

Séjour de formation (Annexe XII)

Le formulaire 3336 est disponible à l'adresse :

<https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/3336.pdf>

Il s'agit de formations de perfectionnement, comme les formations continues, qui s'adressent aux médecins pratiquant en régions éloignées (territoires de couleur autre que beige sur cette carte :

<https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2003/03-913-07.pdf>

Tout médecin qui bénéficie de ces mesures prévues (ressourcement) à l'annexe XII de l'Entente a droit à un maximum de 20 jours par période de 12 mois durant lesquels il a exercé sa profession dans ces territoires.

- **La 1^{re} et 2^e année de pratique**, le médecin a droit de facturer **10 journées de ressourcement + 2 déplacements** (remboursement du moyen de transport, KM, ou billet d'avion)
- **3^e année de pratique** et les suivantes, le médecin peut facturer **20 journées de déplacements + 4 déplacements** (remboursement du moyen de transport, KM, ou billet d'avion)
- Idéalement utiliser les déplacements pour des déplacements longs, par exemple s'il prend l'avion. La RAMQ rembourse 1,19 \$ par km s'il est en voiture personnelle, donc moins payant que s'il prend l'avion.
- **Délai de 90 jours** pour pouvoir facturer
- Les journées **sont cumulatives** d'une année à l'autre (mais ne peuvent pas excéder 80 jours)
- Le médecin reçoit une allocation de **846\$ par jour** de formation.
- **Le remboursement des frais de transport aller-retour** du lieu de résidence jusqu'au lieu de la formation (max. 4 fois par année)
- Une **allocation forfaitaire de 258\$ par jour** pour la compensation des frais de séjour (logement, repas, autres frais)
- Congrès sur place : le médecin peut également, s'il le désire, demander sa journée avant et après la formation pour compenser ses journées de déplacement où il n'a pas pu travailler. On réclame alors sa journée comme une journée de formation + son allocation forfaitaire pour chacune des journées. Il peut facturer à son choix 1 journée ou une ½ journée, **peu importe la durée de la formation**.
- Si le médecin assiste par webdiffusion, il n'a pas le droit au déplacement, ni à l'allocation forfaitaire de 258\$ pour les frais de séjour et les journées avant et après. **Seul le 846\$ par jour de ressourcement est payable. 3 heures = ½ journée et 6 heures = 1 journée complète.**

- Pour les congrès hors Québec (à l'international, par exemple République dominicaine), le médecin doit faire une demande d'autorisation à la FMOQ **avant la formation** en envoyant le programme.
- **Formulaire 3336** : Doit être envoyé **par la poste** à la RAMQ avec l'attestation de présence et toutes les pièces justificatives du déplacement s'il y a lieu (billets d'avion, de train, de taxi, facture d'essence si voiture)

La procédure complète sera fournie sur demande.

Si nous faisons la réclamation pour vous, veuillez nous transmettre l'attestation de présence et mentionner le nombre de jours à réclamer. Si vous vous êtes déplacé pour votre séjour de formation, les pièces justificatives originales sont requises.

Ex : stationnement, reçu de taxi, billet d'avion (exceptionnellement la Régie acceptera une impression du billet électronique) et autres, et mentionner le jour avant et après à réclamer.

Veuillez contacter le (la) responsable de votre dossier pour obtenir la procédure complète si vous désirez faire vous-même votre réclamation.

Si vous désirez qu'on la fasse pour vous, veuillez nous transmettre une copie de l'attestation de présence et préciser si nous devons réclamer des journées de déplacement.



Plan Élite – des frais de 25 \$ par réclamation seront exigés.

Plan Agence – ceci est inclus dans votre tarif annuel.

Facturation Hors RAMQ

GUIDE DE FACTURATION PRIVÉE OMNIPRATICIEN

Voici l'information pertinente pour être en mesure de récolter la bonne information lorsque vous voyez des patients non couverts par la RAMQ afin de vous assurer un paiement pour les services rendus. De plus, vous y verrez quelques conseils selon le type de facturation.

Prendre note que nous offrons le service de réclamation pour la facturation privée.
Veuillez vous référer à l'agence de facturation afin de connaître le tarif pour toute réclamation.

Lorsque vous nous transmettez l'information, il est important d'avoir le nom complet, la date de naissance, le diagnostic, l'établissement où le patient a été vu, la plage horaire ou l'heure exacte et le nom du médecin qui a vu le patient.

- * Pour toute réclamation lorsqu'il y a une consultation, vous devez avoir le nom du médecin référent.
- * Il est important de nous transmettre le diagnostic, car celui-ci peut avoir une incidence sur le paiement.
- * Prendre note que le délai de paiement pour les types de facturation hors RAMQ est de 3 mois à 1 an.

Hors province

Obligatoire :

- Formulaire original (aucune photocopie n'est acceptée) ;
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/2688.pdf>
- Nom de la province ;
- Numéro de carte santé ;
 - Ontario : 10 chiffres
 - Nouveau-Brunswick : 9 chiffres
 - Colombie-Britannique : 10 chiffres
 - Saskatchewan : 9 chiffres
 - Terre-Neuve : 12 chiffres
 - Alberta : 9 chiffres
 - Manitoba : 6 chiffres
 - Nouvelle-Écosse : 10 chiffres
 - Île-du-Prince-Édouard : 8 chiffres
 - Territoires-du-Nord-Ouest : une lettre et 7 chiffres
- Signature du patient ou de son représentant (famille ou autre) ;
- Signature du médecin ;
- Adresse complète du patient.

Délai de réclamation :

- 12 mois pour les provinces sauf la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique
- Nouvelle-Écosse : 6 mois
- Colombie-Britannique : 6 mois pour les patients hospitalisés et 90 jours pour les patients vus à l'externe et en cabinet

Aucune couverture santé

Vous pouvez demander au patient de vous payer directement votre partie d'acte professionnel lors de la visite. Nous n'agissons pas à titre de collection directement chez un patient.

CNESST

Tous les actes, formulaires, visites, chirurgies effectués en lien avec un accident de travail doivent être facturés à la RAMQ. Veuillez fournir la date d'accident.



Plan Élite – vous devez facturer le patient sans NAM en sélectionnant la situation « patient requiert des soins urgents ». Ne pas oublier d'inscrire une date d'accident dans la case date d'événement.

Assurance

Obligatoire :

- Numéros de contrat
- Certificat et le nom de la compagnie
- Formulaire complet fourni par le patient ou sa compagnie

OU

- Copie de la carte d'assurance du patient (Certificat# – Contrat# – ID# requis)
- Les coordonnées de l'assureur.

Détenu provincial

SVP, facturez à la RAMQ.

Détenu fédéral

Obligatoire :

- Nom de l'établissement
- Adresse du centre correctionnel.
- Numéro SED si possible et date de naissance du détenu.
- Nom de l'officier référent de l'établissement.

Immigrant

Obligatoire :

- Numéro d'identification à 8 chiffres ou 10 chiffres (**ID** ou **ICU**)
- Date de naissance

Vous serez inscrit comme fournisseur Croix-Bleue par FACNET, afin de procéder à vos futures réclamations et demandes de paiement.

Délai de réclamation : 6 mois

Numéro de téléphone de la Croix-Bleue : 1 888 614-1880

Lien utile : <https://www.medaviebc.ca/fr/professionnels-de-la-sante/ressources>

SAAQ

Obligatoire : indiquer le type de rapport médical

Types de rapports :

- Initial : 34\$
- D'évaluation : 91\$
- D'évolution : 91\$
- De séquelles : 86\$

Militaire

Obligatoire :

- Copie de la carte militaire pour le numéro d'identification. ID militaire : (M xxxxxx)
- Numéro de téléphone de la Croix-Bleue : 1-888-260-4033

Lien utile : <https://www.medaviebc.ca/fr/professionnels-de-la-sante/ressources>

PARTICULARITÉ POUR LES BÉBÉS

Militaire

Si l'un des parents a un NAM RAMQ, on peut le réclamer avec celui-ci à la RAMQ, sinon il doit payer les frais médicaux.

Immigrant

Les parents doivent communiquer avec le service des citoyens afin de fournir, s'il y a lieu, l'admissibilité du bébé à la Régie, sinon, ils devront payer les frais médicaux et, s'il y a lieu, se faire rembourser.

Hors province

Si le bébé n'a pas de numéro de carte santé, ils devront payer les frais médicaux et se faire rembourser dans leur province.

Aucune couverture santé

Vous pouvez demander au patient de vous payer directement votre partie d'acte professionnel lors de la visite. Nous n'agissons pas à titre de collection directement chez un patient.

Peuples autochtones

Peu importe la réserve, celui-ci doit avoir un numéro de carte santé de la province.

Grille provinciale des tarifs

POUR LES SERVICES NON ASSURÉS, DÉASSURÉS ET LES FRAIS CONNEXES EFFECTUÉS PAR DES MÉDECINS DE FAMILLE

Ces tarifs sont suggérés par la FMOQ. Les taxes exigibles sont en sus. Pour obtenir la version la plus récente de cette grille :

<https://www.fmoq.org/pratique/facturation/frais-accessoires/grille-tarifaire-et-affichage-des-frais-admissibles/>

ANNEXE 1 – Codes des visites de facturation

VISITE DE PRISE EN CHARGE

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	79 ans et moins	15801 (85,75 \$)	15802 (99,40\$)
Non vulnérable	80 ans et plus	15815 (101,80 \$)	15816 (118,50\$)
Vulnérable	79 ans et moins	15821 (96,35 \$)	15822 (110,00\$)
Vulnérable	80 ans et plus	15835 (112,40 \$)	15836 (129,15 \$)

VISITE DE SUIVI D'UN PATIENT INSCRIT

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	79 ans et moins	15803 (42,85 \$)	15804 (49,15 \$)
Non vulnérable	80 ans et plus	15817 (50,65 \$)	15818 (58,25 \$)
Vulnérable	79 ans et moins	15823 (53,50 \$)	15824 (59,80 \$)
Vulnérable	80 ans et plus	15837 (61,30 \$)	15838 (68,85 \$)

VISITE PÉRIODIQUE DU VULNÉRABLE

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Vulnérable	79 ans et moins	15819 (96,35\$)	15820 (112,40\$)
Vulnérable	80 ans et plus	15839 (112,40\$)	15840 (129,15\$)

VISITE PÉRIODIQUE PÉDIATRIQUE (0-63 mois)

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	0 à 63 mois	15813 (66,90\$)	15814 (75,85\$)
Vulnérable	0 à 63 mois	15833 (77,55\$)	15834 (86,45\$)

VISITE PONCTUELLE MINEURE

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	79 ans et moins	15765 (20,40\$)	15766 (23,55\$)
Non vulnérable	80 ans et plus	15769 (24,25\$)	15770 (28,05\$)
Vulnérable	79 ans et moins	15767 (31,00\$)	15768 (34,15\$)
Vulnérable	80 ans et plus	15771 (34,90\$)	15772 (38,65\$)

VISITE PONCTUELLE COMPLEXE

Patient inscrit	Âge du patient	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	79 ans et moins	15773 (40,80\$)	15774 (47,05\$)
Non vulnérable	80 ans et plus	15777 (48,50\$)	15778 (56,05\$)
Vulnérable	79 ans et moins	15775 (51,40\$)	15776 (57,65\$)
Vulnérable	80 ans et plus	15779 (59,10\$)	15780 (66,65\$)

VISITE DE SUIVI DE GROSSESSE

Patient inscrit	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus
Non vulnérable	15811 (50,20\$)	15812 (57,00\$)
Vulnérable	15831 (60,80\$)	15832 (67,60\$)

VISITE DE PRISE EN CHARGE DE GROSSESSE

Premier trimestre	Avec référence (transfert) à un autre médecin	Code de facturation Moins de 500 patients	Code de facturation 500 patients et plus	Vulnérable
Oui	Non	15805 (132,80\$)	15806 (151,15\$)	Non
Oui	Oui	15807 (85,75\$)	15808 (97,75\$)	Non
Non	Non	15809 (85,75\$)	15810 (97,75\$)	Non
Oui	Non	15825 (143,40\$)	15826 (161,65\$)	Oui
Oui	Oui	15827 (96,35\$)	15828 (108,40\$)	Oui
Non	Non	15829 (96,35\$)	15830 (108,40\$)	Oui

VISITE D'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE

8819 (99,40\$) Patient inscrit ou non, inscrire le nom du médecin référent.

VISITE DE SUIVI PSYCHIATRIQUE

8848 (73,20\$) Patient inscrit ou non, inscrire le nom du médecin référent.

VISITE D'ÉVALUATION

Type	Code	Inscription
Mineure	15789 (40,60\$)	Patient inscrit ou non
Complexe	15790 (63,00\$)	Patient inscrit ou non

ANNEXE 2

Actes fréquemment utilisés

Acte	Description
105	Cuti-réaction (intradermo-réaction ou scarification), par test. Maximum 2 fois par période de 12 mois.
113	Analyse de laboratoire en cabinet ou à domicile : glycémie (par méthode biochimique quantitative incluant le prélèvement).
403	Examen microbiologique, bactériologique, mycologique à l'état frais et après coloration, la culture et l'antibiogramme.
474	Injection intradermique, sous-cutanée et intramusculaire à des fins de prévention et de traitement, inoculation, vaccination, etc. Facturable lorsque fait sans examen.
1166	Excision chirurgicale (incluant la fermeture simple) tronc, bras et jambe, diamètre de trois (3) cm ou moins.
341	Électrocardiogramme : technique et interprétation.
529	Injectons de substances sclérosantes dans une veine variqueuse des membres inférieurs, autres injections : une ou deux. Injection au-delà de la deuxième (maximum douze (12)) : 1,95 \$.
1165	Excision chirurgicale (incluant la fermeture simple) cuir chevelu, cou, mains, pied, organes génitaux externes, diamètre de trois (3) cm ou moins.
402	Examen microbiologique à l'état frais et/ou après coloration d'un frottis cervico-vaginal.
205	Insertion de stérilet incluant l'examen ou la consultation effectuée antérieurement ou concurremment à cet égard (supplément de vulnérabilité facturable avec ce code). Il n'est pas possible de facturer une visite avec cet acte.
125	Monitoring continu de la pression artérielle, par technique non invasive, par période de vingt-quatre (24) heures, interprétation. Ne peut être facturé pour des patients hospitalisés.
410	Extraction de fécalome volumineux.

EXPLORATION DE PLAIES

Indiquez le nombre total de cm dans l'espace réservé à cet effet pour les réparations de plaie ou les débridements, ex : 1323:3.

Si plus d'une plaie, inscrire le nombre total pour chaque plaie et nous informer qu'il s'agit d'un site anatomique différent.

Ex : une plaie à la jambe droite 5 cm et une plaie au bras gauche 5 cm, vous inscrivez 1323:5,1323:5#SI93. La colle et le sterile strip sont acceptés.

Acte	Description
1320	Lacérations simples face et cou. Pour la réparation de lacérations simples, la somme des centimètres s'additionne à la valeur de base qui n'est payable qu'une fois. Moins d'un (1) cm.
1323	Lacérations simples, localisation autre que face et cou. Pour la réparation de lacérations simples, la somme des centimètres s'additionne à la valeur de base qui n'est payable qu'une fois. Moins d'un (1) cm.
1326	Plaie : exploration d'une plaie sous anesthésie, exploration, sans réparation, d'une plaie complexe, qui nécessite un transfert à un autre médecin, débridement isolé de plaie (excluant les brûlures).
2323	Réinsertion de muscle ou réparation de déchirure musculaire
2396	Suture ténorrhaphie, suture tendineuse : doigt, main, poignet, cheville, pied, tendon extenseur (du même membre).
1327	Débridement isolé de plaie (excluant les brûlures).
1215	Onyctomie, doigt ou orteil (incluant le lambeau, le cas échéant).
1216	Onyctomie, doigt ou orteil (incluant le lambeau, le cas échéant). --- radicale : exérèse de la matrice unguéale et amputation partielle de la phalange distale, si nécessaire.

LES UNITÉS

*Par exemple, pour facturer 3 réductions fermées interphalangiennes sur la même main (2666), inscrivez à côté du code **2666:3**.*

CORPS ÉTRANGERS

Acte	Description
1196	Peau - Exérèse de corps étrangers simples
3194	Extraction de corps étranger du nez par rhinoscopie
7197	Oreille externe - Excision - Corps étranger ou polype (autre que cérumen et tube)
7806	Cornée - Curetage et/ou cautérisation sous anesthésie locale
7204	Extraction d'un corps étranger conjonctival sous anesthésie locale
7154	Extraction d'un corps étranger cornéen sous anesthésie locale
791	Extraction d'un corps étranger de l'hypopharynx ou des amygdales

BRÛLURE 2^e DEGRÉ

Les brûlures simples (1^{er} degré) sont incluses dans le tarif de l'examen ou autre service associé.

Acte	Description
1330	Brûlures importantes (2 ^e et 3 ^e degré), traitement initial, incluant débridement et pansement, moins de 10% de la surface corporelle.
1331	Brûlures entre 10 et 30%, incluant débridement et pansement.
1800	Traitement subséquent, incluant débridement et changement de pansements de 20 cm carrés ou plus, par quart d'heure.

ÉPISTAXIS

Acte	Description
3801	Tamponnement nasal antérieur, par mèche
3804	Cautérisation de la cloison
3807	Tamponnement nasal, tube gonflable

ENSEIGNEMENT DU DIABÈTE

Acte	Description
9313	Enseignement de la technique de la mesure de la glycémie capillaire (maximum une (1) fois par patient par année)
335	Traitement initial par patient (maximum 1 fois par patient, tous médecins confondus)
9315	Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables : vérification du traitement, par période de trois (3) mois, par patient

DRAINAGE HÉMATOME

Acte	Description
1007	Incision et drainage d'un hématome ou d'un sérome : sus-fascial ou sus-aponévrotique
1008	Incision et drainage d'un hématome ou d'un sérome : sous-fascial ou sous-aponévrotique
1009	Fenestration d'un ongle pour évacuation d'hématome

DRAINAGE ABCÈS

Acte	Description
1005	Incision et drainage d'un abcès sus-fascial ou sus-aponévrotique; unique ou multiple
1006	Incision et drainage d'un abcès sus-fascial ou sus-aponévrotique; unique ou multiple
1001	Incision et drainage d'un abcès parois

INFILTRATION

Acte	Description
431	Injection de médicament dans une bourse séreuse, une articulation, ou les deux, incluant l'aspiration préliminaire (maximum trois (3))
430	Injection de médicament dans capsules, gaines, tendons, ligaments ou fascia
255	Blocage d'un nerf somatique important tel radial, cubital, etc., incluant la technique pour localiser le point moteur

PONCTION (INCLUANT L'INJECTION)

Acte	Description
683	Ponction artérielle pour prélèvement sanguin
254	Drainage de la bourse séreuse ou articulaire thérapeutique incluant prélèvement diagnostique, pour culture et/ou étude biochimique
596	Ponction lombaire avec ou sans épreuve manométrique

FRACTURE ET IMMOBILISATION

Acte	Description
2712	Phalange, réduction fermée
2626	Phalange distale (P3), réduction fermée
2554	Fascia fasciotomie compartiment interosseux
2621	Métacarpien, réduction fermée, un ou plusieurs
2711	Métatarsien, réduction fermée : un ou plusieurs au même pied
2534	Omoplate, réduction fermée

2623	Phalange proximale et/ou moyenne (P1-P2), réduction fermée
2807	« Taping » du pied ou de la cheville
2863	Immobilisation temporaire de fracture avec ou sans réduction temporaire qui nécessite un transfert à un autre médecin
2820	Doigt
2823	Main
2800	Membre supérieur (bras, coude, avant-bras) ou inférieur (cuisse, genou, jambe)
2848	Pied
2828	Main et poignet
2559	Clavicule, immobilisation simple
2751	Cheville, réduction fermée
2662	Coude, réduction fermée
2546	Épaule gléno-humérale, réduction fermée
2657	Tête rad. (coude), traitement de pronation douloureuse (pulled elbow)
2525	Mâchoire temporo-mandibulaire, réduction fermée
2666	Interphalangienne, réduction fermée, une
2756	Interphalangienne, réduction fermée, une
2737	Genou, réduction fermée incluant la surveillance

ANNEXE 3

Les actes inclus

Selon le préambule général, voici la liste des actes compris dans l'honoraire de l'examen, de la consultation ou d'un autre service médical associé, la rémunération des services médicaux ci-après énumérés, à savoir :

Ablation des points de suture ou des agrafes

Ablation de shunt artérioveineux (hémodialyse)

Administration et interprétation des tests diagnostiques suivants :

- analyse d'urine, sans microscopie
- glycémie, par méthode simple qualitative
- hémoglobine, par méthode simple qualitative
- mycose test
- P.P.D. (purified protein derivative)
- test à la tuberculine
- toute autre analyse par méthode simple, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

Allongement du frein du prépuce

Androscopie

Application de pâte d'Unna

Appréciation simple de l'acuité visuelle et auditive

Aspiration de la trachée sous vision directe

Aspiration pour otite séreuse, unilatérale

Biomicroscopie oculaire

Biopsie du pénis

Biopsie du scrotum

Blocage de nerf honteux, uni ou bilatéral

Blocage paracervical

Botte d'Unna

Brûlure simple (1er degré), traitement et débridement

Calibrage de l'urètre

Cannulation de canaux galactophores pour reperméabilisation

Cardioversion chimique

Cathétérisme vésical (sonde urinaire), sauf autrement prévu au tarif

Cautérisation du cordon ombilical

Changement de canule de trachéotomie

Changement de cathéter de gastrostomie

Changement de cathéter suprapubien ou de sonde de cystostomie
Changement de sonde d'urétérostomie cutanée
Changement de sonde de néphrostomie
Chimiothérapie d'une lésion cutanée
Correction de symphyse des grandes et petites lèvres sans anesthésie générale
Cure d'hyposensibilisation, sauf celle spécifiquement prévue au tarif
Cryothérapie d'une lésion
Culdoscopie

Débimétrie (débit de pointe)

Détorsion manuelle de cordon spermatique
Dilatation d'urètre chez la femme
Dilatation du col
Dilatation du prépuce
Dilatation du sphincter anal sans anesthésie
Dilatation du vagin sous anesthésie
Dilatation ou irrigation de la voie lacrymale

Électrorétinographie, technique simple

Enlèvement de mèches vaginales
Enlèvement de plâtre (sans fracture ni luxation)
Épilation des cils
Épreuve de Schirmer (hypo-sécrétion lacrymale)
Épreuve pour pacemaker implanté sous électrocardiogramme
Épreuves de fonction respiratoire :

- analyse de gaz artériels et de l'équilibre acidobase, toute technique
- analyse des tensions gazeuses de l'air alvéolaire
- bronchspirométrie (volumes, ventilation en oxygène pour chaque poumon ou chaque lobe)
- évaluation régionale de la ventilation et de la perfusion au moyen de substances inhalées ou injectées
- oxymétrie et saturation en oxygène, toute technique
- ventilation et consommation d'oxygène

Épreuves orthostatiques

Étude de la transmission neuromusculaire

Étude du chimisme gastrique (intubation et interprétation)

Étude du sperme

Étude simple de la vision des couleurs

Évaluation de la motilité oculaire intrinsèque et extrinsèque

Examen à la lampe à fente

Examen externe du globe oculaire et de ses annexes, détermination simple du champ visuel

Examen gynécologique avec cautérisation ou conisation ou électroconisation avec anesthésie

Examens vestibulaires (bilatéraux) : épreuves cervicales

Épreuves de la poursuite

Épreuves positionnelles

Épreuves rotatoires (angulaires, pendulaires, cupulométrie)

Exérèse de cathéter de dissection veineuse

Exérèse de cérumen
Exérèse de tube de drainage, oreille moyenne
Exérèse de varicocèle par voie scrotale
Exérèse d'un corps étranger intravaginal
Exophtalmométrie
Exploration du contenu scrotal
Extraction de bague (acte simple)
Extraction simple de stérilet

Fixation d'un drain

Fracture d'apophyse épineuse ou transverse, traitement conservateur
Fracture du crâne, traitement conservateur
Funduscopie, sauf autrement prévu au tarif

Grattage, pelage, taillage de callosités (lorsqu'effectué en établissement ou au bénéfice d'un patient âgé de moins de soixante-dix (70) ans)

Immobilisation par appareil ou orthèse préfabriqués commercialement incluant notamment :

- collet cervical
- bandage élastique ou adhésif
- écharpe
- etc.

Incision latérale ou dorsale du prépuce

Inhalothérapie

Injection de substance de contraste :

- cholangiographie par injection intraveineuse
- cholangiographie par tube en T
- déférentographie
- échographie
- gynécographie
- orbitographie
- pariétographie
- pelvigraphie
- pyélographie I.V.
- tomographie axiale
- vaginographie
- voies urinaires pour urétérographie

Injection intracaverneuse de papavérine

Injection pour prurit anal

Injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire ou intraveineuse, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

Insertion de pessaire

Insertion de prothèse testiculaire

Insertion naso-gastrique de tubes (Levine, alimentation, etc.)

Insertion de tiges laminaires

Installation de l'équipement de l'inhalothérapie
Installation et contrôle de la phonographie et de l'ECG du fœtus
Installation d'un tube de gavage à long terme
Insufflation tubaire
Irrigation de l'œil
Irrigation et enlèvement du drain

Laryngoscopie à suspension, sans anesthésie ou sous anesthésie locale;
Laryngoscopie au microscope sans anesthésie ou sous anesthésie locale;
Laryngoscopie directe (rigide), sans anesthésie ou sous anesthésie locale
Laryngoscopie indirecte sans biopsie
Lavage bronchique
Libération du frein de la langue pour un patient de deux (2) ans et moins

Manipulation pour épicondylite (tennis elbow)
Manœuvre d'Epley
Manométrie ano-rectale (sauf pour une pathologie digestive)
Massage prostatique
Mesure de la tension veineuse centrale
Mesure de la vitesse circulatoire
Mise en place d'une mèche dans un kyste déjà drainé
Myringotomie avec mise en place d'un tube de drainage sans microscopie

Nettoyage de l'oreille externe et moyenne

Ophthalmoscopie
Orbitographie avec substance de contraste

Pansement de moins de vingt (20) centimètres carrés
Pharyngogramme avec substance de contraste
Phonocardiographie
Ponction ou aspiration biopsique d'hydrocèle
Ponction de sang dans un cathéter
Pose d'une mèche dans le conduit auditif externe
Prélèvement d'une homogreffe pour remplacement au système cardiovasculaire et thoracique
Prélèvement de sécrétions
Prélèvement sanguin capillaire

Réduction manuelle de torsion testiculaire
Réduction manuelle d'hernie inguinale
Réduction manuelle de paraphimosis (toute technique) sans anesthésie
Réflexogramme achilléen avec kinomètre
Réfraction

Taillage des ongles d'orteil

Tamponnement nasal antérieur par compression simple

Test à la lampe de Wood

Test de confrontation

Test de tolérance à l'eau

Tomographie simple

Tonométrie simple

Traction pour scoliose, type Cotrel

Vectocardiogramme

Ventriculoscopie

FACNET

TÉLÉPHONE (SANS FRAIS)
1 866 3FACNET (1866 332-2638)

TÉLÉCOPIEUR (SANS FRAIS)
1 877 322-0008

825, boul. Lebourgneuf, bur. 300
Québec, Qc G2J 0B9

740, rue Notre-Dame Ouest, bur. 1575
Montréal, Qc H3C 3X6

Suivez nous!
facnet.ca



© FACNET 2026 tous droits réservés. Aucune partie de cette présentation ne peut être modifiée, copiée ou utilisée sans le consentement écrit de FACNET. Les informations fournies dans ce document sont d'ordre général et ne sont destinées qu'à des fins d'informations seulement.